

ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ



Презентация занятия по теме №6

Основы десмургии

Общие вопросы



- ▶ **Десмургия** – раздел хирургии, изучающий оптимальные способы наложения бинтовых повязок.
- ▶ **Повязка** – это комплекс средств, используемых в целях защиты ран и патологически измененных поверхностей кожи от воздействия внешней среды.
- ▶ **Перевязочные материалы** – материалы, используемые при операциях и перевязках, а также для изготовления перевязочных средств. К основным видам перевязочных материалов относятся вата, марля, алигнин.
- ▶ **Перевязочные средства** – изделия заводского изготовления, произведенные из марли и ваты, нетканого полотна и других материалов, или на их основе, готовые к медицинскому применению по назначению (бинты, салфетки, повязки, пакеты перевязочные, ватные шарики и тампоны, лейкопластыри и др.).



- ▶ мягкие;
- ▶ отвердевающие;
- ▶ жесткие.

- ▶ давящая (гемостатическая);
- ▶ защитная (асептическая);
- ▶ лекарственная;
- ▶ окклюзионная;
- ▶ корригирующие;
- ▶ укрепляющие (закрепляющие): защитные; лекарственные;
- ▶ повязка с вытяжением: транспортная; лечебная;
- ▶ иммобилизирующие: транспортная; лечебная.

Классификация повязок



По способу крепления:

- лейкопластырная;
- клеевая (клеоловая, коллодиевая и др.);
- косыночная;
- пращевидная;
- Т-образная;
- бинтовая;
- укрепление трубчатым бинтом.

По типу бинтования (бинтовые):

- циркулярная (круговая);
- ползучая (змеевидная);
- спиральная: с перегибом, без перегиба (восходящая, нисходящая);
- перекрещивающая (8-образная (крестообразная));
- колосовидная;
- возвращающаяся;
- черепашья: сходящаяся; расходящаяся;
- сложная (Дезо, Вельпо).

Классификация повязок



► По характеру и цели иммобилизации:

► транспортная иммобилизирующая:

- мягкие иммобилизирующие;
- шинные иммобилизирующие;
- стандартные;
- импровизированные;
- отвердевающие иммобилизирующие, гипсовые шины.

► лечебная иммобилизация:

- шинные иммобилизирующие повязки с использованием лечебных шин;
- использование экстензионно-компрессионных аппаратов;
- использование установочных шин и приспособлений для постоянного вытяжения;
- отвердевающие повязки (гипсовые, крахмальные, клеевые и т. д.).

Назначение перевязочных материалов и готовых перевязочных средств



Осушение операционного поля и раны при хирургических вмешательствах

Удаление из ран продуктов распада тканей, микробов, токсинов

Остановка кровотечений (первая помощь)

Защита ран от вторичного инфицирования и внешних воздействий

Оказание лечебного воздействия на раневой процесс

Наложение согревающих компрессов

Создание иммобилизации и фиксация повязок на пораженной части тела

Основные требования, предъявляемые к перевязочным материалам и средствам



Классификации перевязочных материалов и перевязочных средств



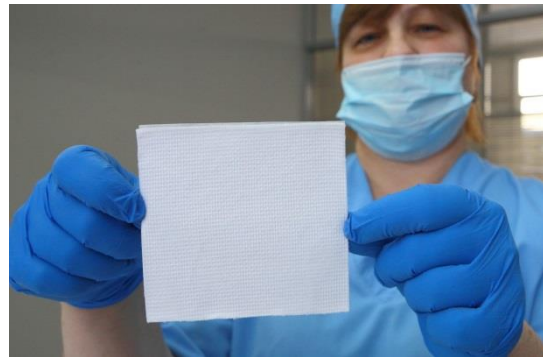
Признак классификации	Разновидности
1. По виду используемых для изготовления сырьевых источников	натуральные, искусственные, синтетические, комбинированные
2. По способу производства и структуре	волокнистые, тканые, нетканые, биосинтетические
3. По условиям применения	для амбулаторного применения, для стационарного применения
4. По назначению	фиксирующие, компрессионные, гемостатические, антисептические, иммобилизирующие, регенерационные, для сведения краёв раны, для повязок ожоговых поверхностей, для оказания первой помощи
5. По способности рассасываться	рассасывающиеся, нерассасывающиеся
6. По степени травматичности	атравматические, неатравматические
7. По степени микробиологической очистки	стерильные, нестерильные
8. По агрегатному состоянию	жидкие, плёночные, губчатые, порошкообразные
9. По форме выпуска	дозированные, фасованные

Классификация и характеристика перевязочного материала



▶ В зависимости от физической структуры различают перевязочный материал:

- ▶ Тканый (марля, бинты медицинские)
- ▶ Вязальный и вязально-прошивной (сетчатый бинт)
- ▶ Нетканый (нетканый прошивной) (лейкопластыри, полотна)
- ▶ Волокнистый (вата, алигнин)
- ▶ Пленочный (пленка алгинатная),
- ▶ Губчатый (гемостатическая и кровоостанавливающая).



- ▶ Тканые, вязальные и нетканые перевязочные материалы выпускаются в виде полотна.

В зависимости от состава перевязочное полотно бывает хлопковым, льняным, вискозным, хлопко-вискозным, бумажным, полимерным и др.

В номенклатуру перевязочного полотна из других групп входят полотно **льняное**, полотно **нетканое холстопршивное безниточное** гигроскопическое медицинское, бумажно-перевязочный материал «Ригрилл» и др.



Классификация перевязочных материалов по основным видам производимой из них продукции



Марля медицинская

- Гигроскопическая (отбеленная)
- Суровая
- Гемостатическая
- Кровоостанавливающая

Вата

- гигроскопическая
- компрессная



Алигнин

- Типа А
- Типа Б



Марля медицинская.

Характеристика



Марля представляет собой редкую сеткообразную ткань для медицинских целей. Выпускается марля

- отбеленная гигроскопическая,
- суровая,
- чисто хлопчатобумажная или с примесью вискозы,
- в рулонах шириной 85-90 см по 50-150 м, а также в отрезах по 2,3,5,10м.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
9412—
2021

МАРЛЯ МЕДИЦИНСКАЯ
Общие технические условия

Издание официальное

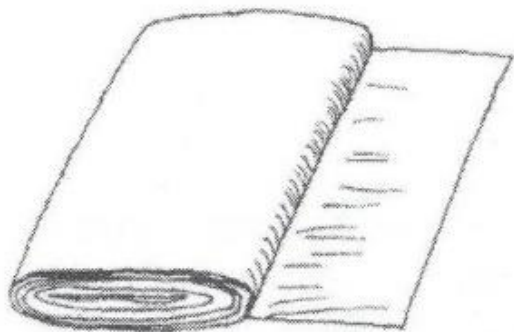
- ▶ Марля с пропиткой – это марля, пропитанная каким-либо лекарственным средством. Чаще всего для пропитки используют дерматол (основная висмутовая соль галловой кислоты), йодоформ или ксероформ.
- ▶ Марля адсорбирующая – это марля, пропитанная различными адсорбентами (Сорбацель, Оксицель, Саргицель). Применяется для тампонирования кровоточащих ран и повреждений паренхиматозных органов.

Бинты

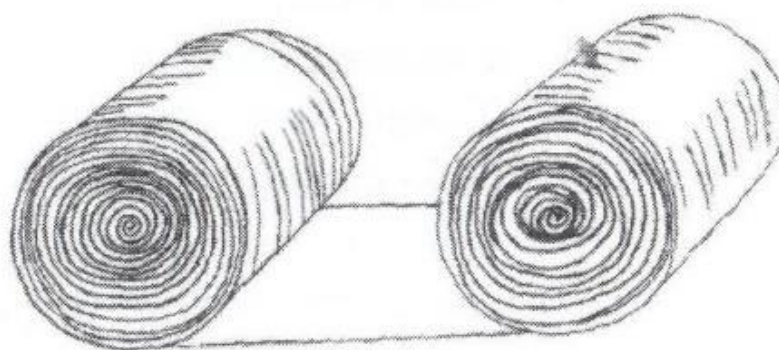
- повязки из марли



- ▶ **узкие** 5 – 7 см (применяют для перевязки пальцев),
- ▶ **средние** 10 – 12 см (применяют для перевязки головы, кисти, предплечья, стопы, голени),
- ▶ **широкие** 14 – 20 см (применяют для перевязки грудной клетки, бедра, молочной железы).



Одноглавый бинт



Двуглавый бинт





Медицинская вата выпускается в двух основных модификациях: гигроскопическая и компрессная, которая предназначена для согревающих компрессов и наложения шин.

Виды ваты:

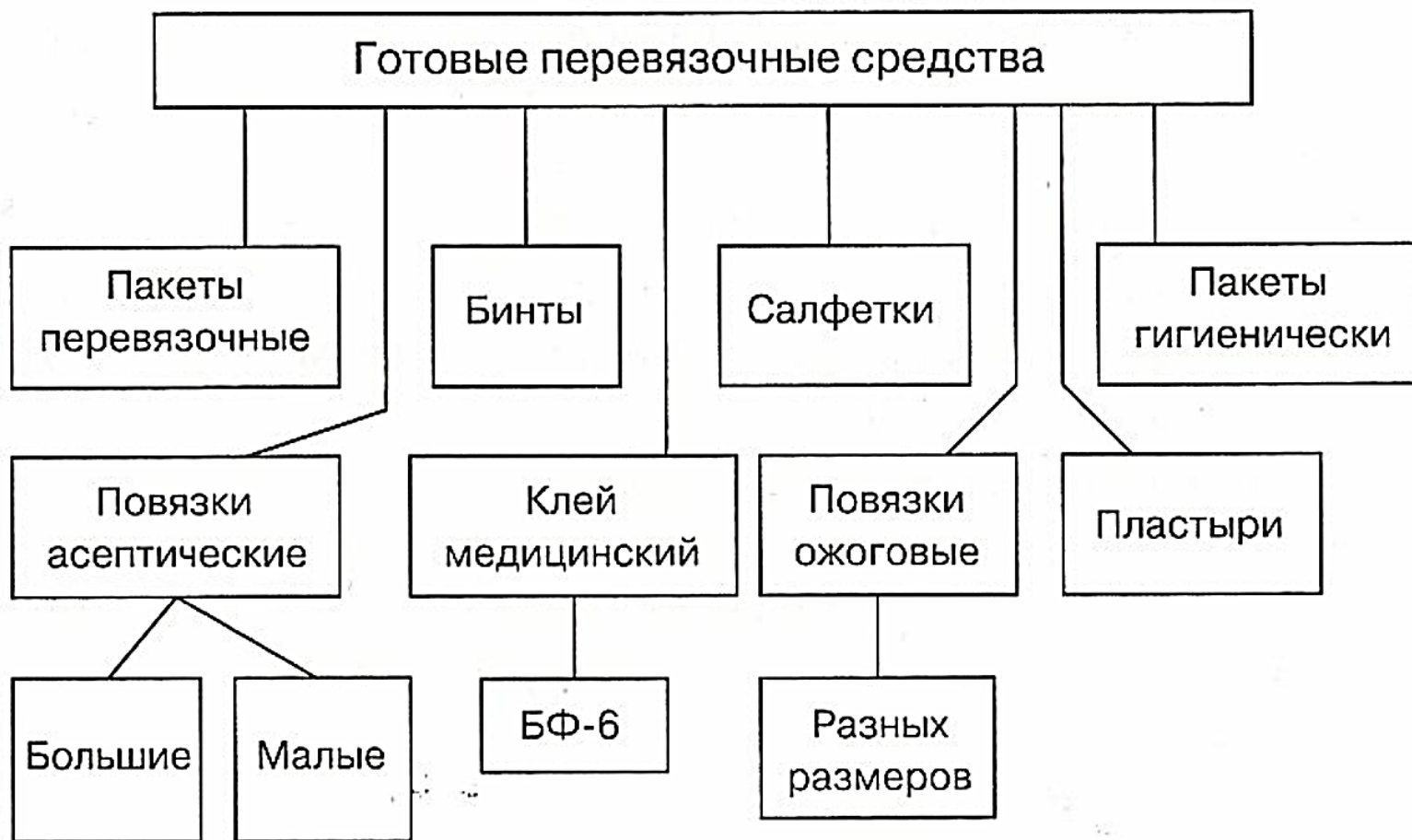
- хлопковая (неотбеленная, очищенная)
- целлюлозная (целлюлозная чистая и вискозная).

Ватой хлопковой называется перевязочный материал, полученный из природных волокон хлопчатника.

Промышленность производит вату перевязочную **неотбеленную компрессную** и вату перевязочную **очищенную (гигроскопическую)**.



Классификация готовых перевязочных средств в зависимости от формы выпуска

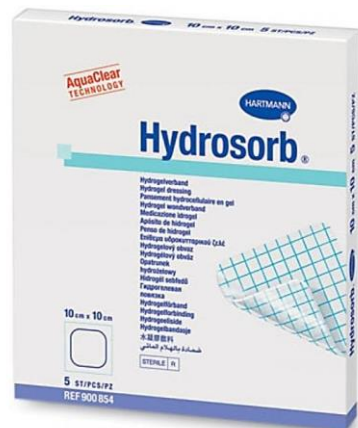


Основные показатели качества перевязочных материалов

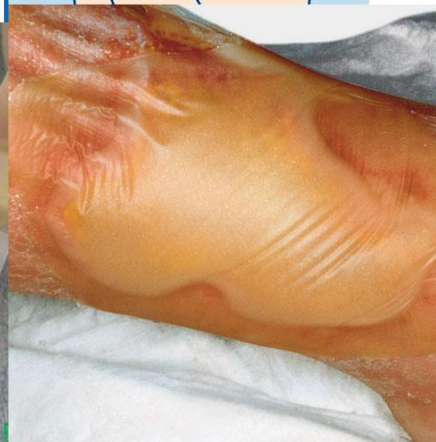
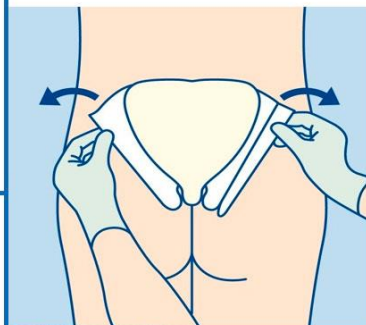


- ▶ **Влажность** – потеря в массе за счет гигроскопической влаги, которую определяют при высушивании до постоянной массы. Оценивается в процентах.
- ▶ **Поглотительная способность** – способность впитывать жидкость (воду, кровь, водные растворы, тканевые жидкости). Оценивается количеством воды в граммах, поглощенной 1 граммом относительно сухой ваты.
- ▶ **Капиллярность** – способность материала поднимать жидкость из нижних слоев материала в его верхние слои. Оценивается высотой поднятия жидкости по материалу в миллиметрах за определенный промежуток времени.
- ▶ **Химическая нейтральность** – нейтральная реакция водной вытяжки – оценивается лакмусовой бумагой.

Современные виды атравматических раневых и лечебных повязок



Современные виды повязок



Гидроколлоидные повязки

Гидрогелевые повязки

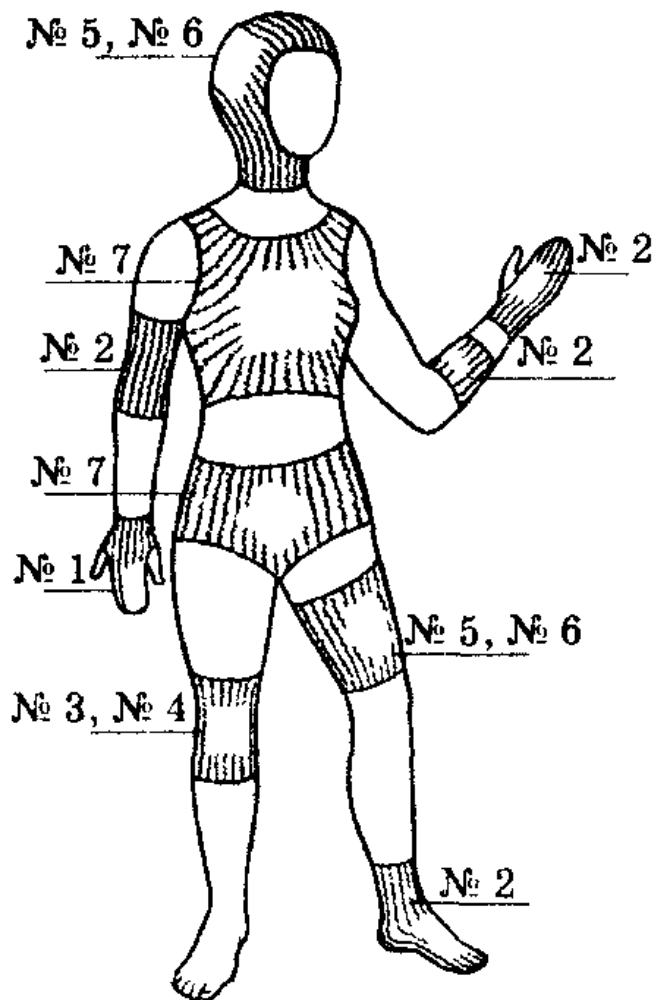


A person is shown from the back, wearing a beige lumbar support brace. The brace features a mesh back panel and two horizontal straps with buckles across the lower back. The person is also wearing dark blue pants.



Корригирующие повязки

Сетчатая повязка



Фиксация мягкой бинтовой повязки



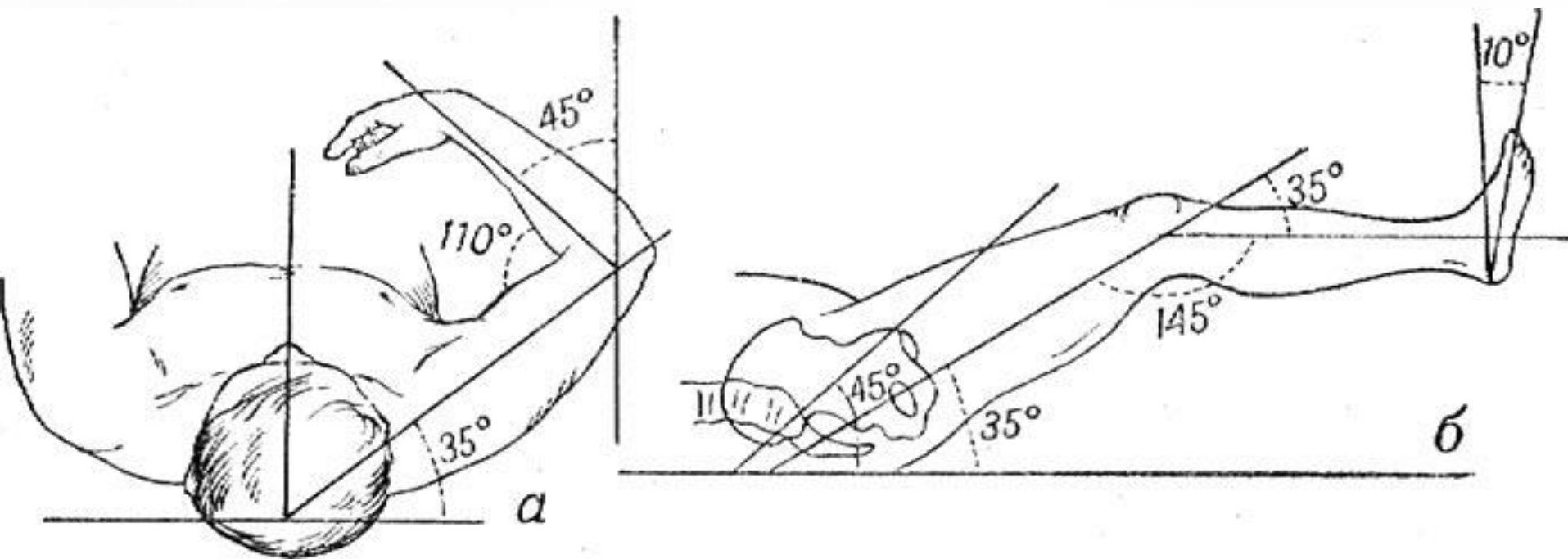
- ▶ Фиксация достигается расщепленным концом бинта, который завязывается узлом в наименее подвижном месте.
- ▶ Разрывать конец бинта удобно на протяжении, достаточном для охвата забинтованного участка тела.
- ▶ Узел нужно завязывать **в стороне от зоны** повреждения.
- ▶ При большой повязке, особенно расположенной одновременно на двух различных областях тела, применяется дополнительная фиксация продергиванием отдельных больших лоскутов бинта длиной 15—20 см через взаимно перекрещивающиеся туры бинтовой повязки с помощью остроконечных инструментов с последующим завязыванием простым узлом.
- ▶ Фиксация возможна с помощью лейкопластырной ленты.



Требования к пациенту



- ▶ Пациент должен находиться в положении, обеспечивающем максимально допустимое мышечное расслабление и свободный доступ к бинтуемой части тела.
- ▶ Практически бывает удобнее бинтовать сидящего пациента с несколько приподнятой верхней или нижней конечностью (в зависимости от участка повреждения).
- ▶ Горизонтальное положение оказывается более выгодным только при бинтовании живота, таза и верхней трети бедра.



Физиологические положения

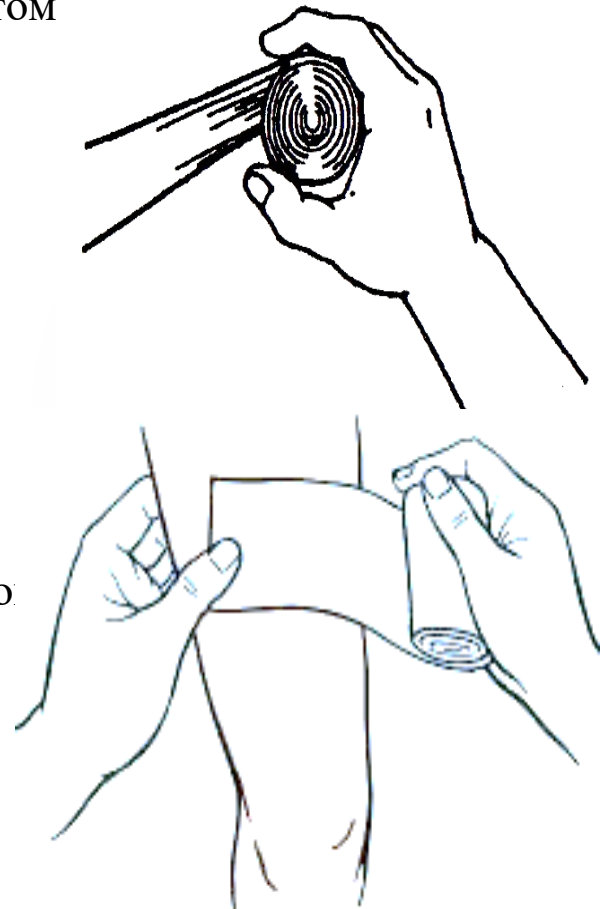


- ▶ **пальцы кисти:** положение легкой ладонной флексии в межфаланговых и пястно-фаланговых сочленениях;
- ▶ **первый палец** противопоставлен остальным и слегка согнут;
- ▶ **кисть** в положении небольшой тыльной флексии (20°) и лучевого отведения ($10-15^{\circ}$);
- ▶ **дистальные отделы предплечья** в положении, среднем между пронацией и супинацией; при опущенной конечности кисть должна находиться в сагиттальной плоскости;
- ▶ **локтевой сустав:** угол сгибания должен составлять $100-110^{\circ}$, положение предплечья среднее между пронацией и супинацией;
- ▶ **плечевой сустав:** конечность свободно свисает вдоль туловища;
- ▶ **тазобедренный сустав:** конечность фиксируется в выпрямленном положении;
- ▶ **коленный сустав:** угол в суставе должен составлять 180° ;
- ▶ **голеностопный сустав:** сгибание под углом 90°

Требования к медицинскому работнику



- ▶ Оператор должен все время находиться лицом к лицу с пациентом
- ▶ Бинтуемый участок должен находиться на уровне груди бинтующего.
- ▶ Повязку накладывают **от дистальных отделов конечностей к проксимальным**
- ▶ Повязку накладывают **слева направо**
Первый и последний туры являются **фиксирующими** и накладываются на более узкие участки (но не на место повреждения)
- ▶ Бинтование производится двумя руками!
- ▶ Бинт должен накладываться при равномерном натяжении в течение всего периода бинтования для предупреждения венозного стаза и отеков конечности.
- ▶ Бинт раскатывают непосредственно на больном, внешней стороной на поверхность тела. Бинт должен катиться по бинтуемой части тела без предварительного отматывания.
- ▶ Перегибы бинта должны быть разумны
- ▶ Каждый следующий тур должен закрывать **1/2 – 2/3** предыдущего
- ▶ Узел нельзя располагать над раной и по задней поверхности тела



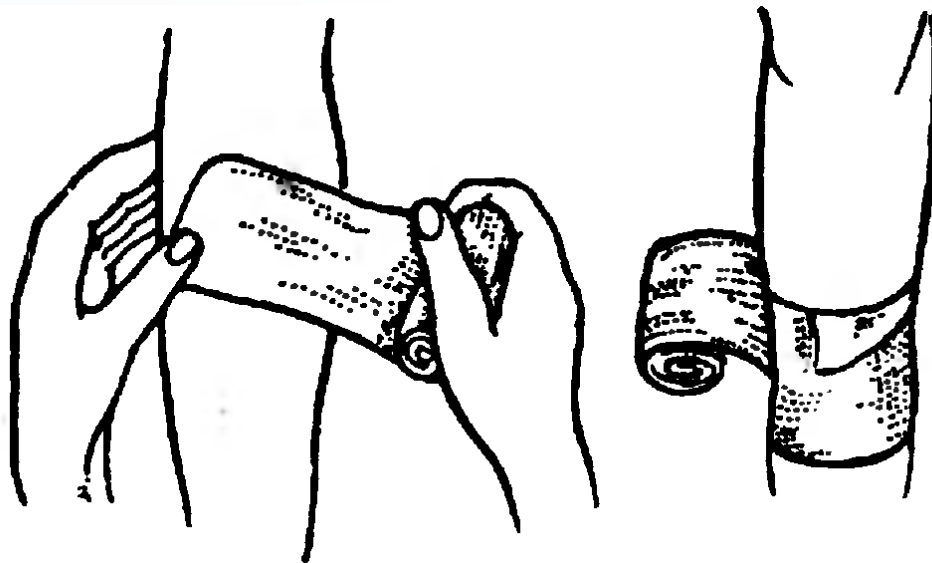


Типы бинтовых повязок

Циркулярная (круговая) повязка



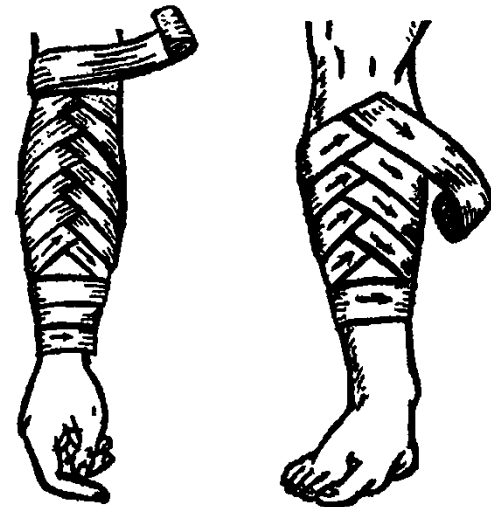
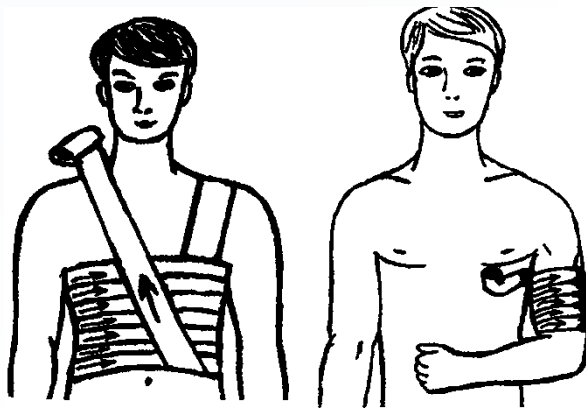
- ▶ Туры бинта полностью прикрывают друг друга.
- ▶ Используется для закрытия небольших ран в области «цилиндрических поверхностей»: лоб, голень, предплечье, шея, живот.
- ▶ Повязка может вращаться при движениях пациента и смещать перевязочный материал (возможность инфицирования, болевого синдрома).



Спиралевидная повязка



- ▶ Является разновидностью циркулярной.
- ▶ Накладывается на конечности, туловище, грудную клетку для закрытия больших по протяженности дефектов или ран.
- ▶ После закрепляющего хода каждый последующий тур прикрывает предыдущий на $1/2$ или на $2/3$.
- ▶ Повязка проста и быстро накладывается, но легко может сползать во время ходьбы или движений.
- ▶ Если спиральный ход бинта не соответствует неровностям бинтуемого участка, накладывают спиральную повязку с перегибами: поворачивают бинт нижней стороной вверх, придерживая его нижний край.
- ▶ Перегибы следует располагать в стороне от раны.



Ползучая повязка



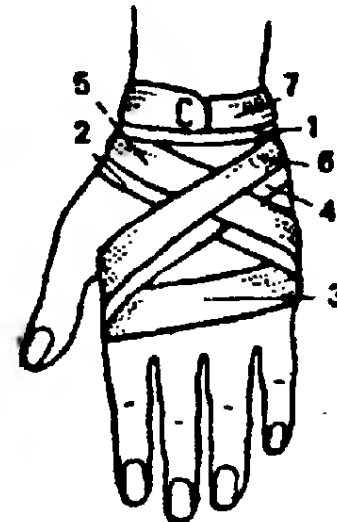
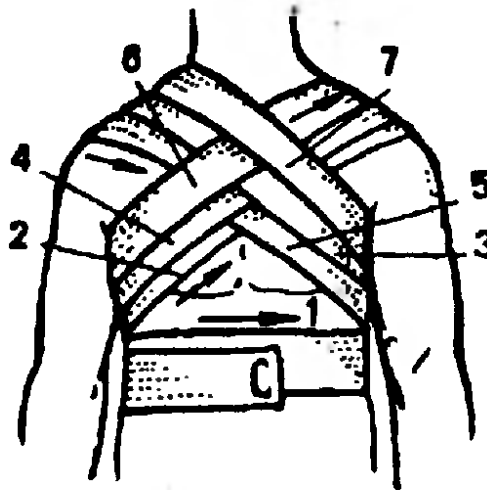
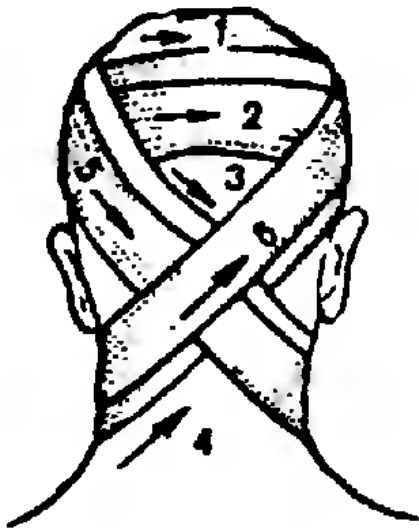
- ▶ Применяется для фиксации большого по протяженности перевязочного материала на конечностях, например при ожогах или скальпированных ранах.
- ▶ Ползучая повязка не является окончательной, но предварительным этапом перед наложением спиральной или какой-либо другой повязки.
- ▶ Использование ползучей повязки устраняет необходимость в лишнем помощнике, позволяет предупредить загрязнение перевязочного материала в процессе наложения повязки, способствует более правильной адаптации перевязочного материала.
- ▶ Начинается с циркулярной повязки и накладывается в проксимальном направлении.
- ▶ Между отдельными турами остается свободное пространство, равное примерно ширине бинта.



Крестообразная (восьмиобразная) повязка



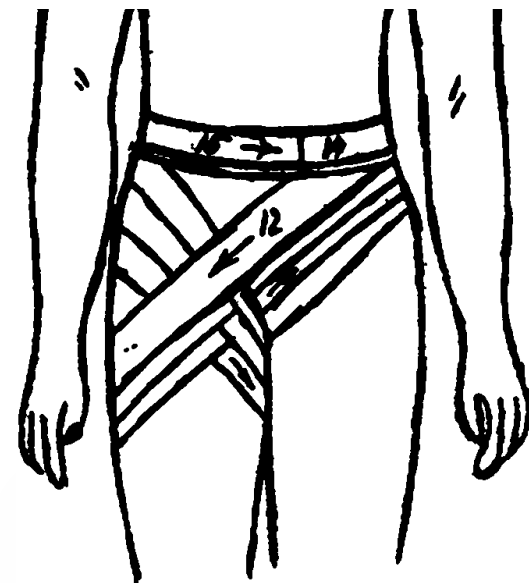
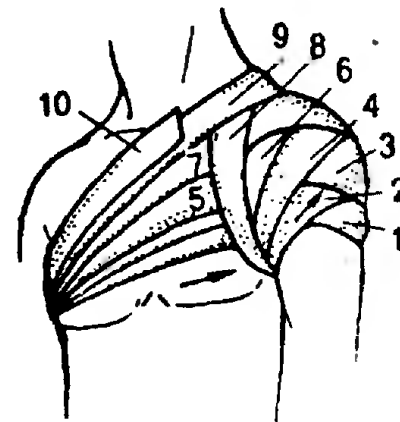
- ▶ Бинт фиксируют круговыми турами, а затем перекрещивают их в виде цифры 8;
- ▶ Повязка используется при бинтовании области затылка, грудной клетки, кисти, голеностопного сустава;
- ▶ При этом все пересечения происходят в одной точке либо на сгибательной, либо на разгибательной поверхности суставов.



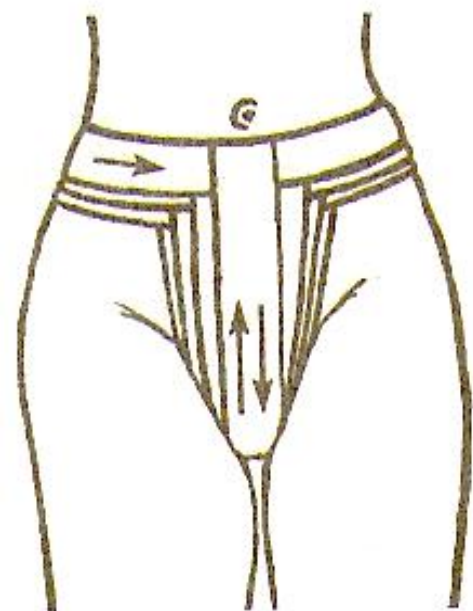
Колосовидная повязка



- ▶ Широко применяется для бинтования плечевого сустава, надплечья и подмышечной области, тазобедренного сустава и других труднодоступных областей.
- ▶ При ее наложении перекресты располагаются по одной линии и смещаются при каждом туре на $1/2$ – $2/3$ ширины бинта.
- ▶ Правильно наложенная повязка не сползает при движениях конечности.
- ▶ При наложении повязки правый плечевой сустав бинтуют по часовой стрелке, левый плечевой сустав – против часовой стрелки.



Петлевые повязки: пращевидные, Т-образные



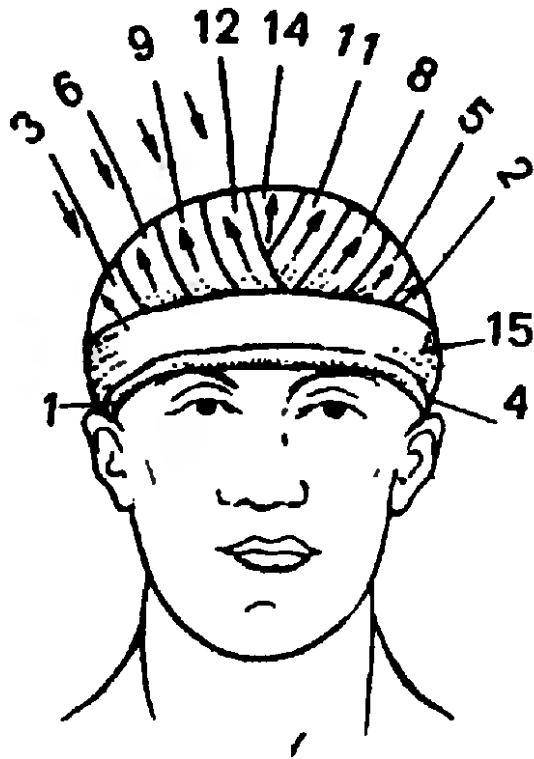
Т-образная повязка



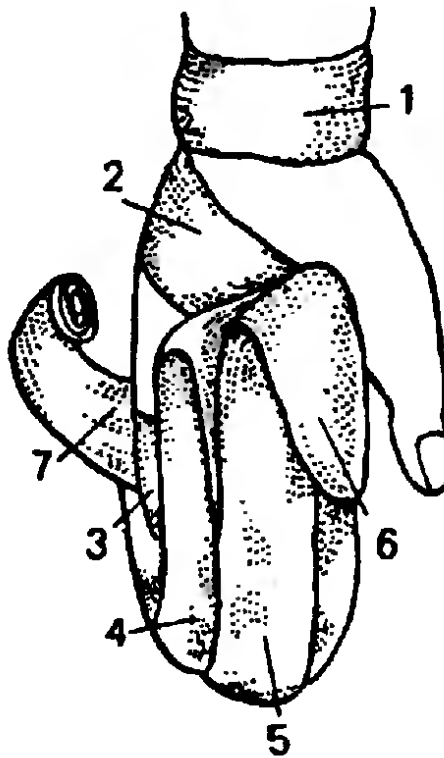
Пращевидная повязка



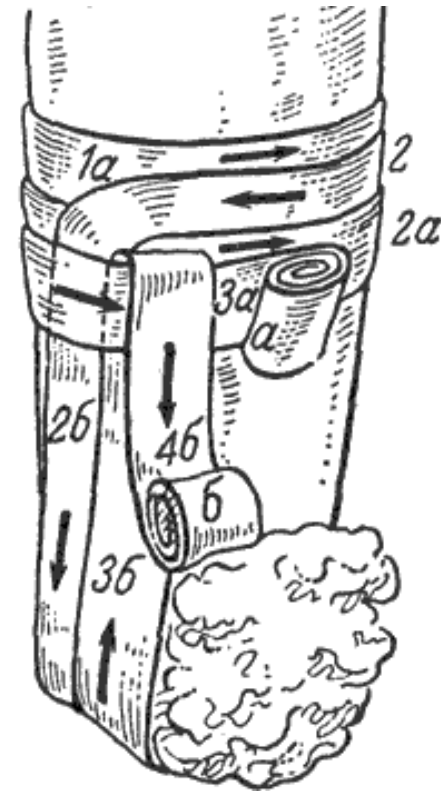
Возвращающаяся повязка



«Шапка Гиппократ»



«Варежка» на кисть



Повязка на культию



Техника наложения бинтовых повязок

Чепец

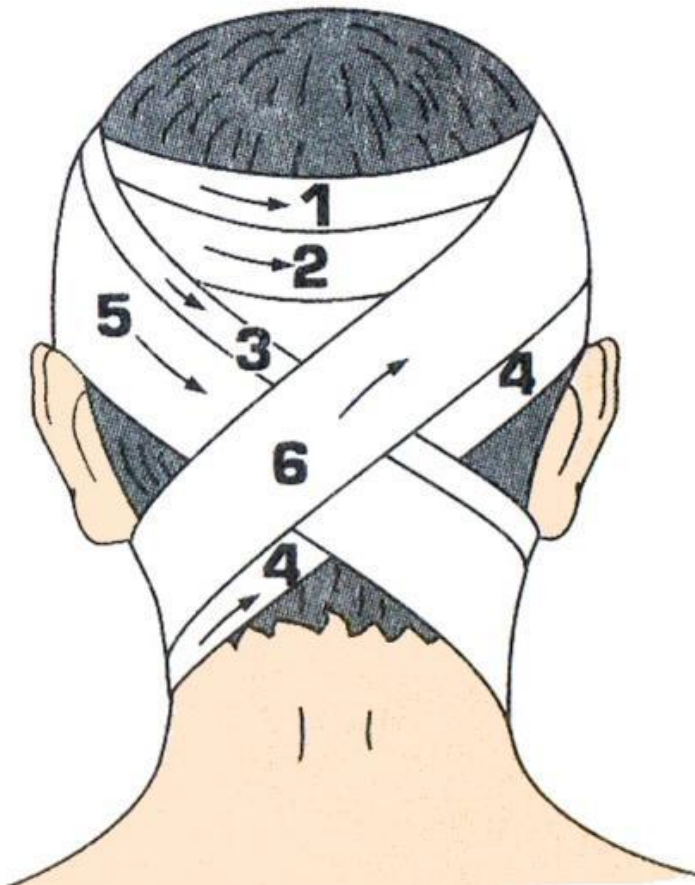


- ▶ Назначение: ранения головы (остановка кровотечения и фиксация перевязочного материала).
- ▶ Оснащение: бинт средней ширины (10 см) и длиной 80 - 90 см.



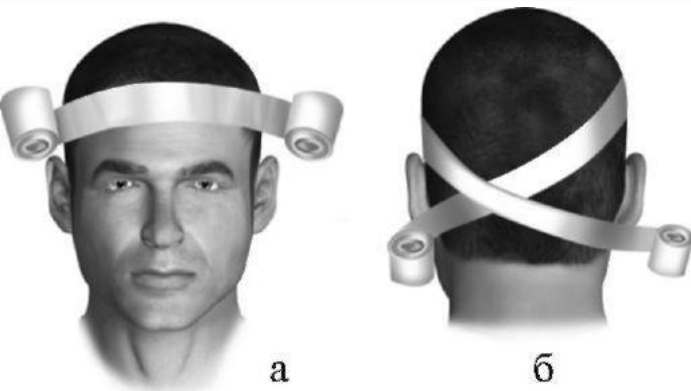
- 1) Взять отрезок бинта длиной 80 – 90 см.
- 2) Расположить середину отрезка бинта на теменную область головы; концы бинта удерживает пациент или помощник. Взять начало бинта в левую руку, головку бинта – в правую.
- 3) Сделать закрепляющий тур вокруг головы.
- 4) Провести бинт по лобной поверхности до завязки.
- 5) Обогнуть ее в виде петли и вести бинт на затылок до противоположной стороны к другой завязке.
- 6) Обернуть бинт снова вокруг завязки и вести по лобной части головы выше закрепляющего тура.
- 7) Аналогично вести бинт по затылочной части головы.
- 8) Повторить циркулярные ходы вокруг головы, прикрывая предыдущий ход на 1/2 или 2/3 до полного покрытия головы.
- 9) Закрыть полностью повторными ходами бинта волосистую часть головы.
- 10) Обернуть бинт вокруг одного из концов завязки и закрепить узлом.
- 11) Завязать под подбородком отрезок бинта, концы которого удерживал пациент.

Крестообразная повязка на затылок



- ▶ **Назначение:** при ранениях затылка или в послеоперационный период при повреждении шеи (остановка кровотечения и фиксация перевязочного материала).
- ▶ **Оснащение:** бинт 5х10см, стерильная салфетка.

Шапочка Гипократа



а

б



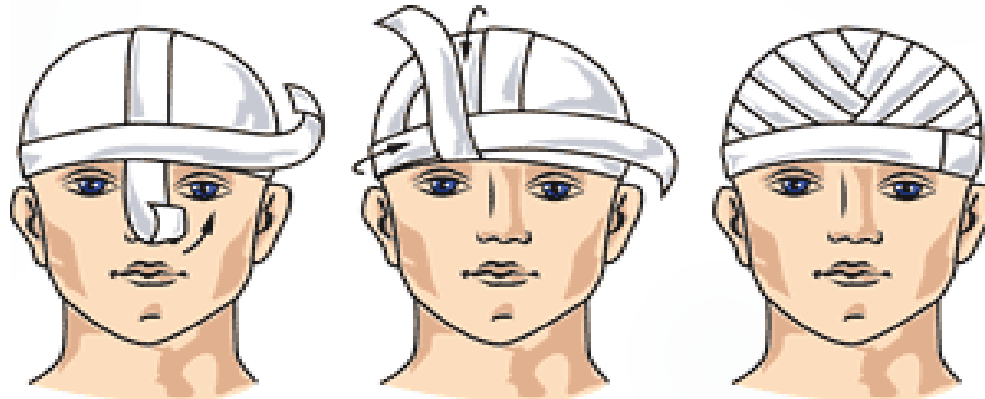
в

г



д

1. Усадить пациента лицом к себе, взять бинт с двумя головками в левую и правую руку. Приложить бинт к затылочной части головы и вести обе головки бинта к лобной области. Сделать перегиб и вести обе головки бинта к затылочной области. Сделать перегиб.
2. Переложить головки бинта: левую головку – в правую руку, а правую головку – в левую руку. Бинт в левой руке вести через теменную область головы к лобной, бинт в правой руке вести вокруг головы к лобной части.
3. Сделать перегиб в области лба. Бинт в правой руке вести через теменную область головы к затылку (закрывая 1/2 предыдущего тура), бинт в левой руке ведем вокруг головы к затылку. Переложить головки бинта из правой руки в левую и наоборот.
4. Бинтовать так до тех пор, пока не закроется теменная область головы.
5. Зафиксировать бинт в левой руке в области затылка; бинтом в правой руке сделать закрепляющий тур вокруг головы.
6. Сделать перегиб в области затылка, вести бинт правой и левой рукой навстречу друг другу к лобной части.
7. Завязать на узел. Срезать остатки бинта.



«Уздечка»



1. Усадить пациента лицом к себе.
2. Первый тур, закрепляющий, наложить циркулярно вокруг головы через лобные и затылочные бугры
3. Провести бинт косо по затылочной области, под ушной раковиной к подбородку и вертикально вверх на противоположной стороне лица спереди от противоположной ушной раковины.
4. Сделать несколько вертикальных круговых ходов через теменную и подбородочную области, спереди ушных раковин.
5. Из-под подбородочной области вывести бинт на затылок, провести косо вверх, выйти на лоб.
6. Сделать циркулярные ходы вокруг головы через затылочные и лобные бугры.
7. Зафиксировать конец бинта на лобной части головы вне раневой поверхности.

Показания

- повреждения лица, нижней челюсти, лобной части головы.

Оснащение:

- бинт шириной 7 – 10 см,
- булавка или лейкопластырь,
- ножницы.



«Неаполитанская» повязка на ухо

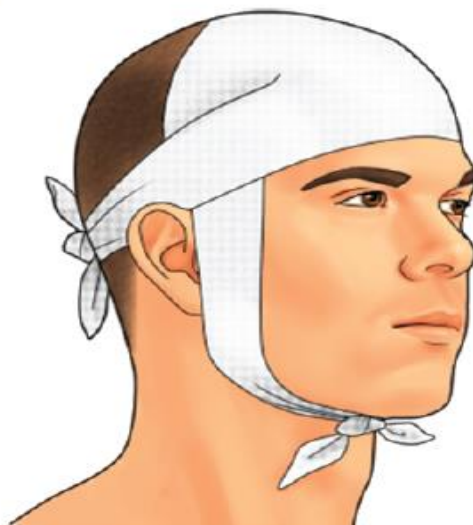


- ▶ **Показания:** повреждения уха.
- ▶ Начинают с фиксирующих циркулярных туров вокруг головы, затем ходы бинта на больной стороне смещают на две трети ширины и опускают все ниже и ниже, постепенно закрывая всю область сосцевидного отростка и ушной раковины. Закрепляют повязку вокруг головы круговым туром и завязывают.

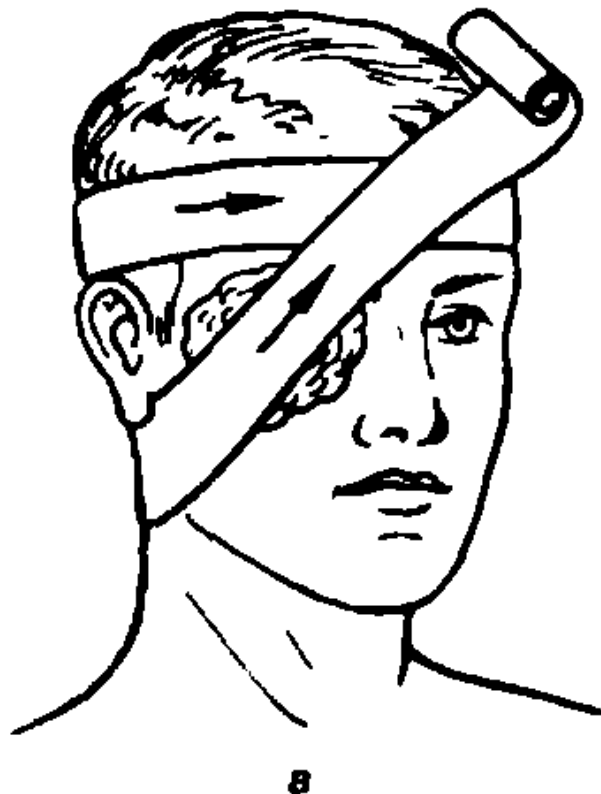
Пращевидная повязка



1. Накладывается на нос, подбородок, промежность.
2. Для изготовления этой повязки берут кусок бинта длиной 50-70 см, разрезают его пополам вдоль с двух сторон, чтобы в середине остался целый кусок бинта размером 10-15 см.
3. Неразрезанную часть накладывают на нос или подбородок, а разрезанные концы перекрещивают и завязывают на затылке.
4. Т-образную повязку промежности изготавливают сходным образом, завязывают к поясу, сделанному из бинта.



Монокулярная повязка



Показания:

- закрепление перевязочного материала в области
- глаза при его повреждениях и заболеваниях.

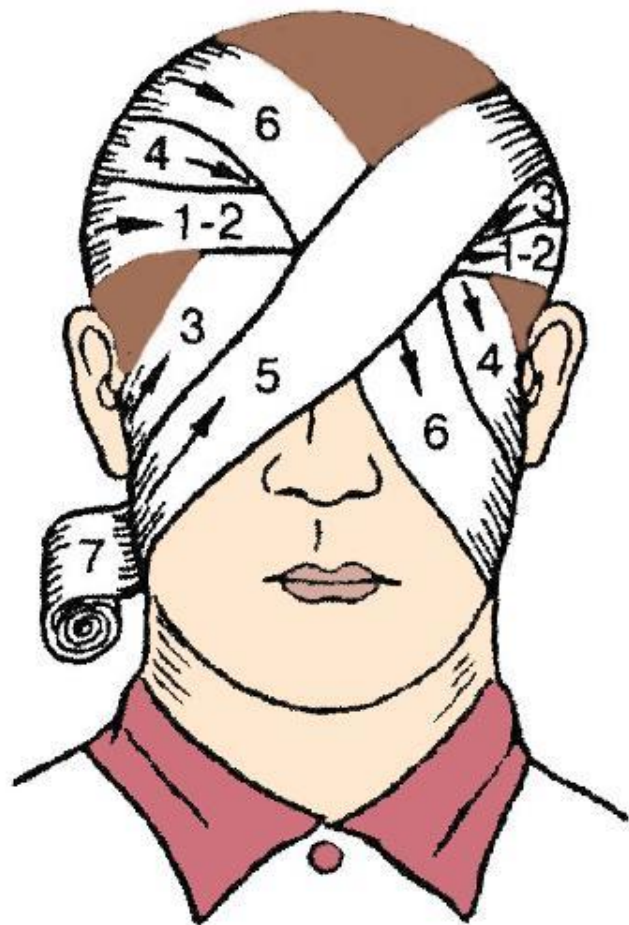
Оснащение: бинт шириной 15 – 20 см, ватно-марлевая прокладка, ножницы, лейкопластырь.

Прикрыть глаз защитной или лечебной ватно-марлевой прокладкой.

Бинтовать левый глаз слева направо, правый – справа налево.

1. Сделать циркулярный закрепляющий ход вокруг головы через лобные и затылочные бугры, начиная со стороны больного глаза.
2. Опустить бинт вниз по направлению к затылку и вести его под мочкой ушной раковины с больной стороны, закрывая этим ходом больной глаз.
3. Сделать закрепляющий тур бинта вокруг лобной и затылочной области головы.
4. Повторить циркулярные ходы вокруг головы и через область глаза несколько раз, закрывая больной глаз.
5. Зафиксировать повязку, разрезав конец бинта и завязав на узел (с другой стороны от поврежденного глаза).

Биноккулярная повязка

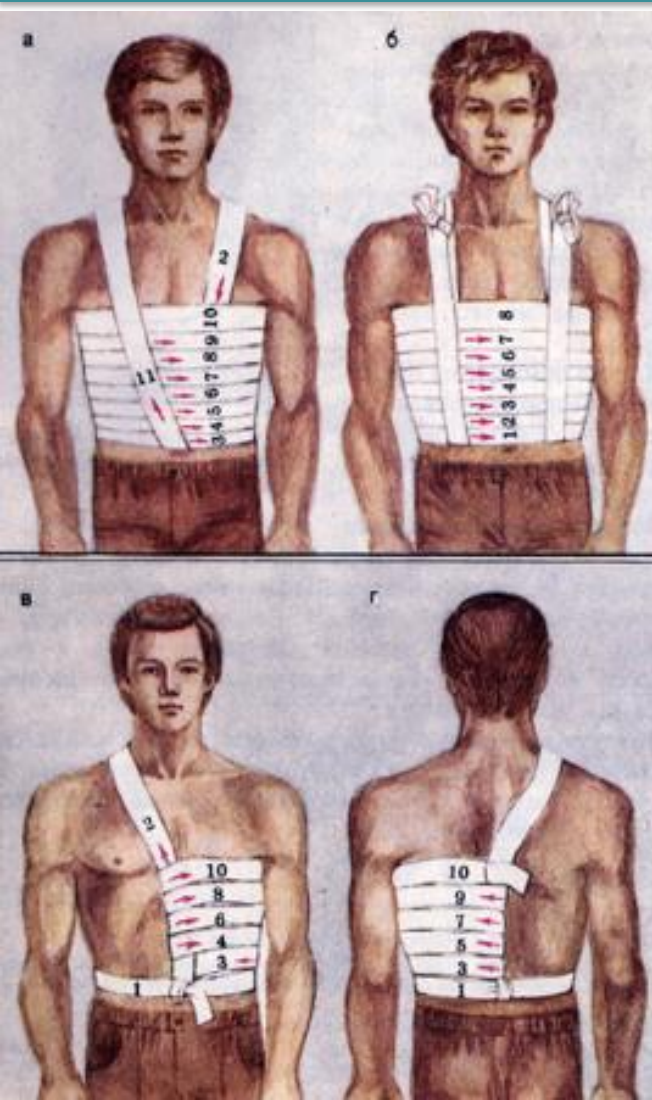


Показания: закрепление перевязочного материала в области глаз при их повреждениях и заболеваниях, послеоперационный период.

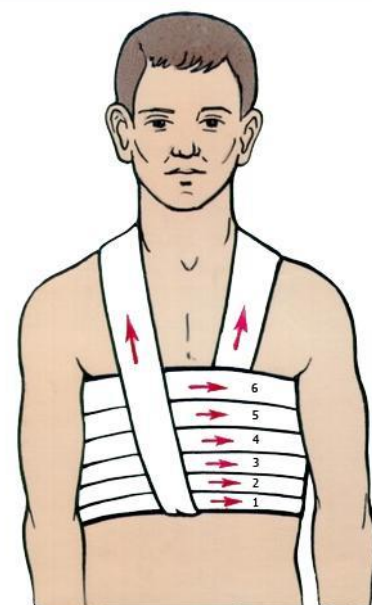
Оснащение: бинт шириной 10 – 20 см, изоляционные ватно-марлевые прокладки, ножницы, лейкопластырь или булавка.

1. Сделать циркулярный закрепляющий тур вокруг головы через лобные и затылочные бугры. Бинтовать слева направо.
2. Провести бинт сзади косо вниз по затылку.
3. Затем вести бинт под мочкой уха, косо через лицевую область и правый глаз на лоб.
4. Сделать циркулярный ход вокруг головы и вести бинт через лицевую область косо вниз через левый глаз под мочку уха на затылок
5. Чередовать туры до закрепления перевязочного материала.
6. Зафиксировать повязку, разрезав конец бинта и завязав на узел на лобной части головы

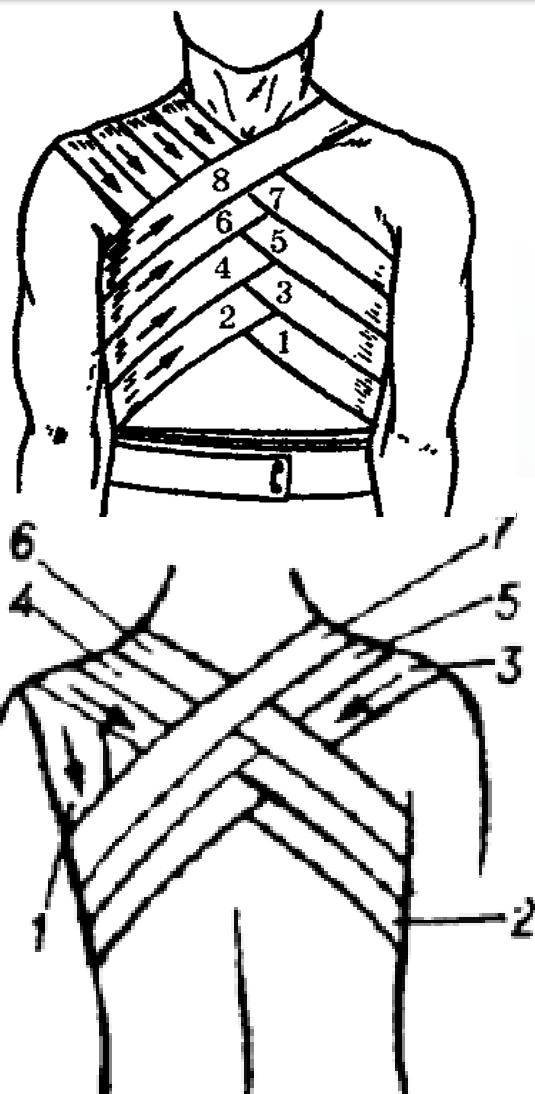
Спиральная повязка на грудную клетку



1. Отрывают от бинта кусок длиной около 100 – 120 см и кладут его серединой на левое надплечье
2. После этого спиральными ходами (3 - 10) по направлению вверх обвивают всю грудную клетку до подмышечных впадин и здесь закрепляют круговым ходом.
3. Свободно висящую часть бинта перекидывают через правое плечо и связывают с концом, висящим на спине.
4. Спиральная повязка будет держаться прочнее, если наложить по полоске бинта на каждое надплечье. При связывании полосок получаются две ламки, удерживающие повязку.



Крестообразная повязка на грудь

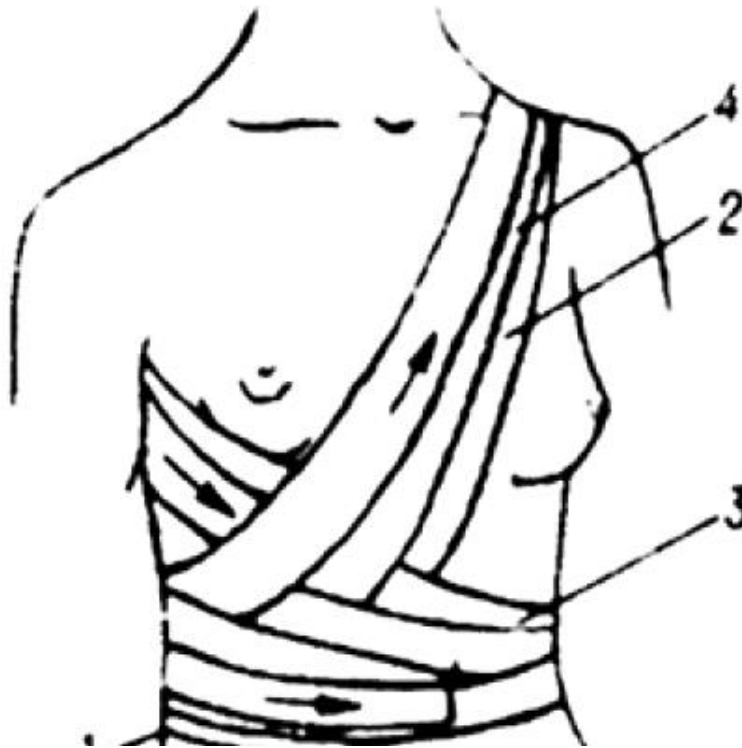


1. Начинается с кругового хода, закрепляющего бинт вокруг грудной клетки (1).
2. Затем на передней поверхности груди бинт ведут вверх в косом направлении справа на левое надплечье (2),
3. через спину поперечно на правое надплечье
4. и спускают косо (3) в левую подмышечную впадину.
5. Затем ведут поперечно через спину в правую подмышечную впадину,
6. отсюда через левое надплечье, повторяя второй и третий ходы.
7. Повязку закрепляют вокруг груди.

Повязка, поддерживающая молочную железу

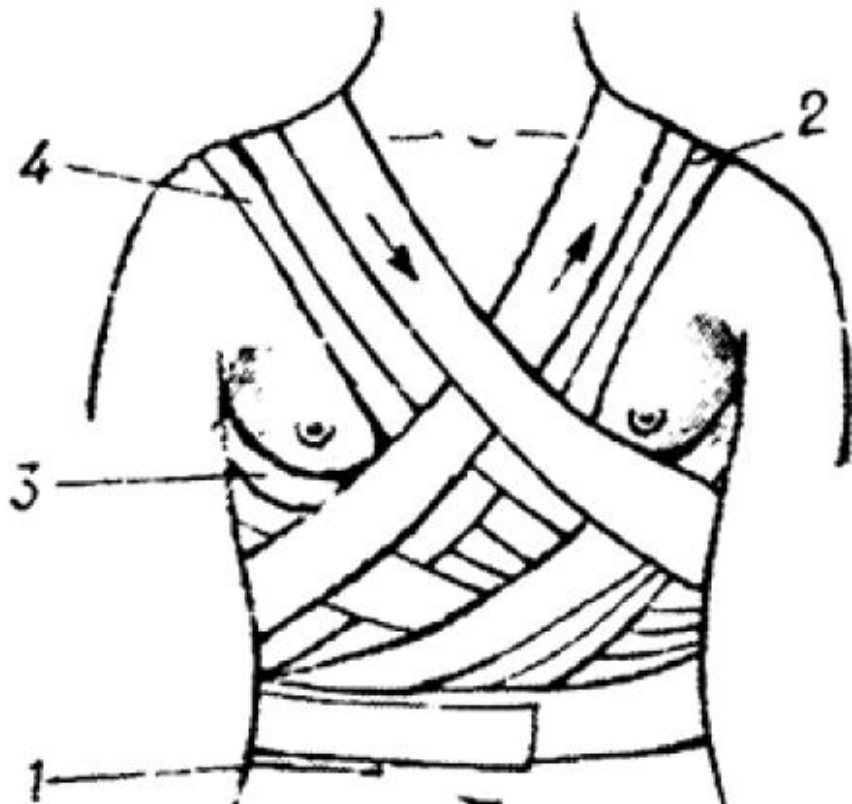


При накладывании на правую молочную железу бинт ведут обычно слева направо, при повязке на левую железу – в обратном направлении.



1. Начинают с круговых ходов ниже молочной железы (1),
2. доходят спиральными ходами до правой молочной железы, а затем, охватив нижнюю и внутреннюю часть ее, ведут бинт на левое надплечье (2),
3. косо сзади по спине в правую подмышечную впадину, отсюда, охватывая нижнюю часть железы (3),
4. и далее опять вверх (4) через больную железу, повторяя ходы — второй и т. д.
5. Закрепляют повязку круговым ходом ниже железы.

Повязка, поддерживающая обе молочные железы



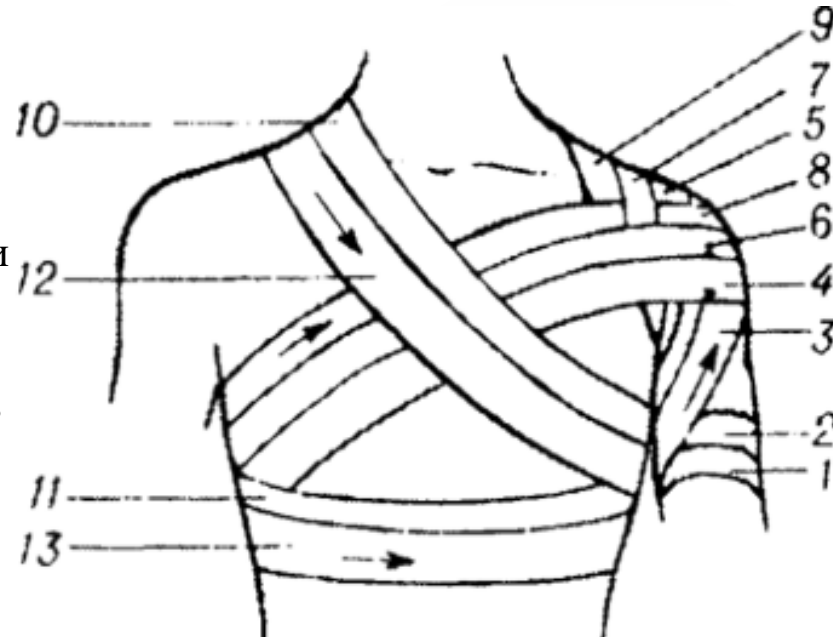
1. Начинается с кругового тура (1).
2. Дойдя до основания правой железы, бинт направляют косо вверх на левое надплечье (2),
3. затем через спину в косом направлении к правой подмышечной впадине и по боковой поверхности груди переходят в горизонтальное направление (3).
4. Пройдя под левой молочной железой, бинт ведут косо через спину на правое надплечье и спускают вниз (4), в промежуток между молочными железами, прикрывая левую, и закрепляют горизонтальными ходами.
5. Все эти обороты чередуются, пока не будут закрыты обе железы.

Повязка на подмышечную область

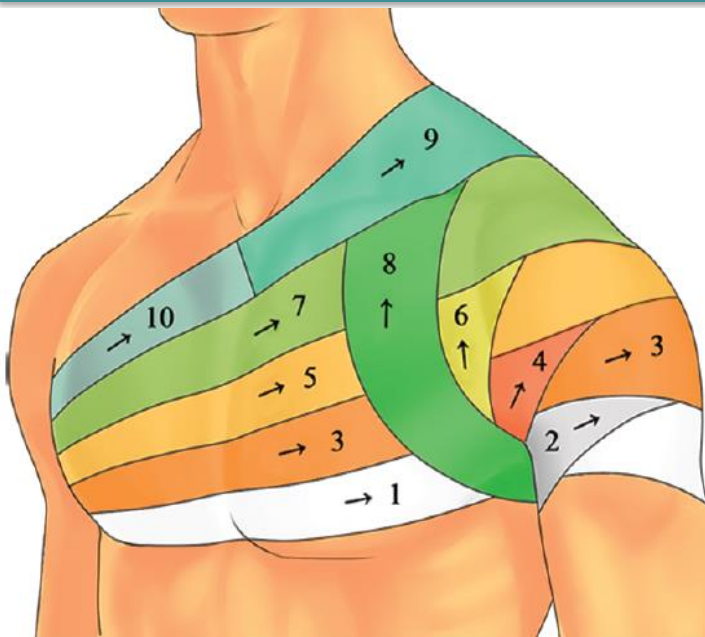


Наложив перевязочный материал, всю подмышечную область прикрывают слоем ваты, причем вата переходит за границы ее, и прикрывают частично верхнюю часть грудной стенки с боков и внутреннюю поверхность плеча в верхнем отделе.

1. Повязку начинают двумя круговыми турами в нижней трети плеча (1—2),
2. затем делают несколько ходов колосовидной повязки (3—9)
3. и ведут косой ход по спине и груди через надплечье здоровой стороны в больную подмышечную область (10 и 12).
4. Затем делают круговой ход, охватывающий грудную клетку и удерживающий вату (11 и 13).
5. Последние два хода по грудной клетке — косой и круговой — чередуются несколько раз.
6. Повязку закрепляют несколькими ходами колосовидной повязки плеча.

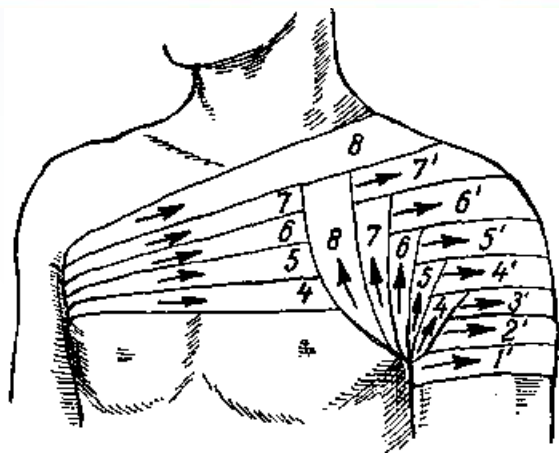


Колосовидная повязка на плечевом суставе



- ▶ **Показания:** закрытые травмы и ранения плечевого сустава, гнойно-воспалительные заболевания плечевого пояса подмышечной области и верхней трети плеча, артрозы, артриты плечевого сустава, раневая поверхность в области плеча.
- ▶ Повязку накладывают **по направлению к больной стороне.**
- ▶ Оснащение: бинт шириной 20 см, булавка.

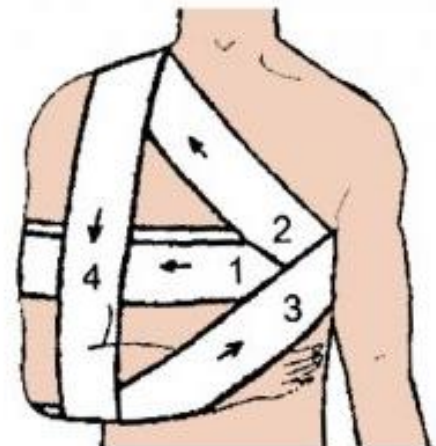
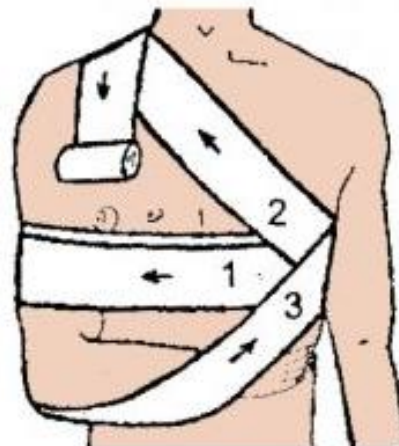
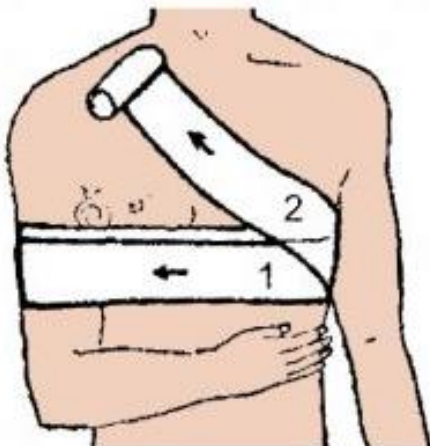
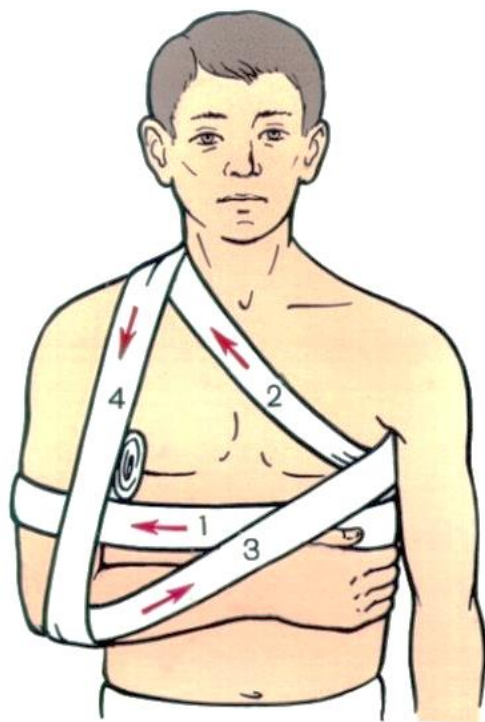
1. Усадить пациента лицом к себе.
2. Опустить конечность вдоль туловища.
3. Сделать два тура бинта вокруг грудной клетки.
4. Вести бинт по спине через здоровую подмышечную впадину на переднюю поверхность грудной клетки.
5. Перевести бинт на плечо и, перекрещивая ранее наложенный тур, сделать петлю вокруг плечевой кости с внутренней стороны.
6. После перехлеста в области плечевого сустава бинт снова наложить на предыдущий тур, закрывая его на 2/3 ширины.
7. Вести бинт по спине в подмышечную впадину на здоровой стороне.
8. Повторять ходы бинта, пока не закроется весь сустав.
9. Закрепить конец бинта на груди булавкой



Повязка Дезо (Desault)



- **Показания:** вывих плеча, профилактика рецидивов; перелом плечевой кости, ключицы, лопатки; повреждения связок; параличи верхних конечностей; артриты, периартриты и артрозы; вторичные миозиты, невриты, парезы и плекситы; период восстановления после операций на верхней конечности и ношения гипса.



Повязка Дезо (Desault)



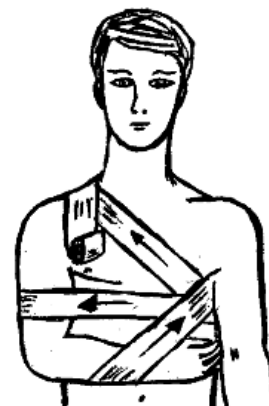
1. Вложить в подмышечную впадину валик из ваты, обернутый марлей. Очень осторожно согнуть поврежденную конечность в локтевом суставе, привести и прижать к груди.
2. Сделать два закрепляющих тура бинта по груди, больной руке в области плеча, спине и подмышечной впадине со стороны здоровой конечности.
3. Вести бинт через подмышечную впадину здоровой стороны по передней поверхности груди косо на надплечье больной стороны.
4. Опустить бинт вниз по задней поверхности больного плеча под локоть.
5. Обогнуть локтевой сустав и, поддерживая предплечье, направить бинт косо в подмышечную впадину здоровой стороны. Вести бинт из подмышечной впадины по спине на больное надплечье.
6. Вести бинт с надплечья по передней поверхности больного плеча под локоть и обогнуть предплечье. Направить бинт по спине в подмышечную впадину здоровой стороны. Повторять туры бинта до полной фиксации плеча.
7. Закончить повязку двумя закрепляющими турами по груди, больной руке в области плеча, спины. Заколоть конец повязки булавкой. Если повязка наложена на длительное время, туры бинта следует прошить.



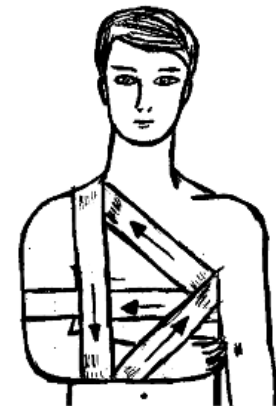
а



б



в



г

Повязка Вельпо

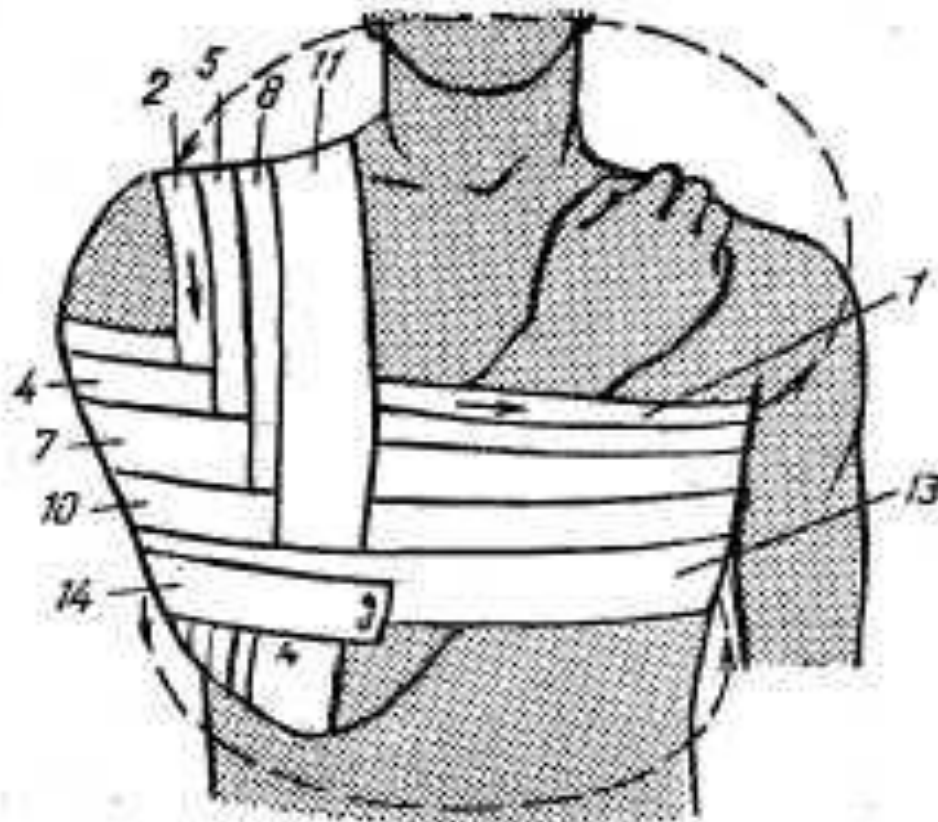


Рис. 75. Повязка Вельпо. Цифры — порядковые номера туров.

Сходящаяся «черепашья» повязка

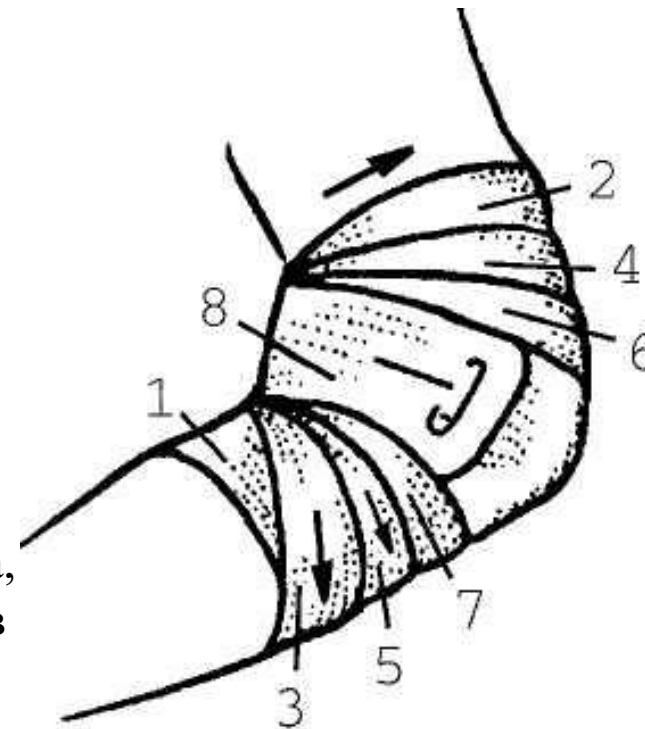


Показания: повреждения выше или ниже локтевого сустава.

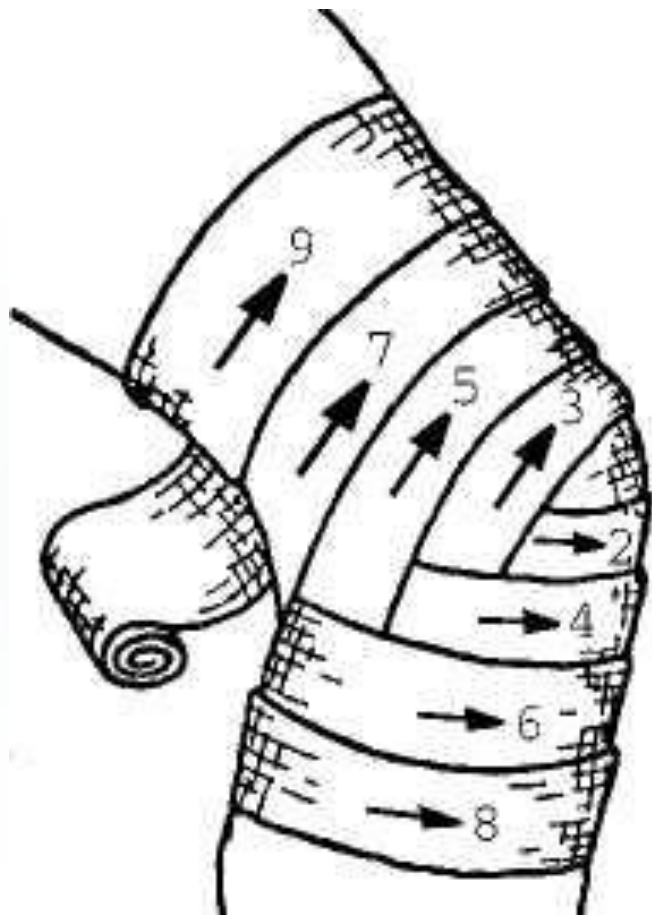
Оснащение: бинт шириной 20 см.

На коленный сустав повязка накладывается аналогичным образом

1. Согнуть конечность в локтевом суставе.
2. Наложить 2 – 3 закрепляющих тура бинта вокруг нижней трети плеча.
3. Косо пересечь бинтом сгибательную поверхность локтевого сустава и перевести его на верхнюю треть предплечья.
4. Сделать горизонтальный тур вокруг предплечья.
5. Наложить ходы бинта на плечо и предплечье друг на друга, постепенно сближаясь после восьмиобразных перекрестов над сгибательной поверхностью локтевого сустава.
6. Закрыть локтевой сустав, опустившись в область предплечья.
7. Зафиксировать повязку, разрезать конец бинта и завязать концы на узел.



Расходящаяся «черепашья» повязка

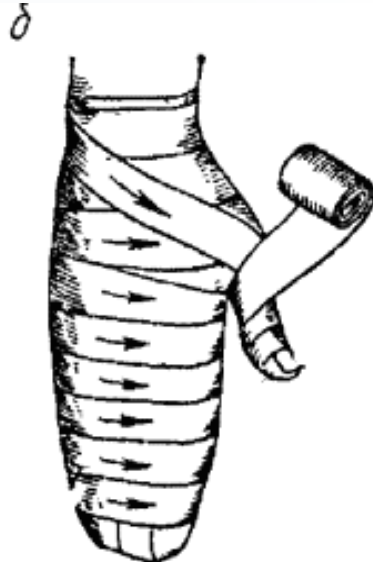
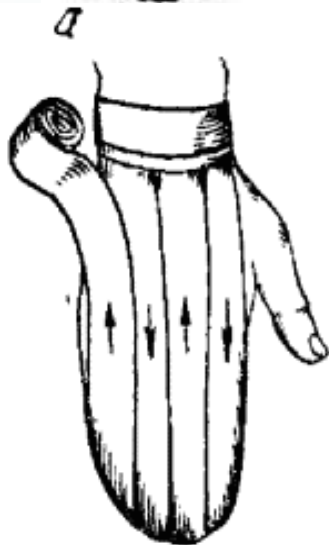
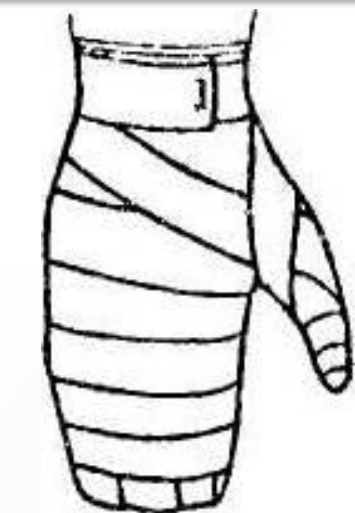


Показания: повреждения сустава.

Оснащение: бинт шириной 20 см.

1. Согнуть сустав в физиологическом положении
2. Приложить бинт к суставу
3. Сделать два закрепляющих тура бинта вокруг сустава
4. Перевести бинт с сустава на нижнюю треть предплечья
5. Пересечь сгибательную поверхность сустава и перейти на верхнюю треть предплечья
6. Перевести бинт с предплечья через локтевую ямку на плечо, прикрывая предыдущий тур на $1/2$
7. Перевести бинт с плеча через локтевую ямку на предплечье, прикрывая предыдущий тур на $1/2$
8. Вести бинт попеременно на плечо и предплечье, перекрещиваясь в локтевой ямке.
9. Закрепить повязку в нижней трети плеча.

«Варежка»



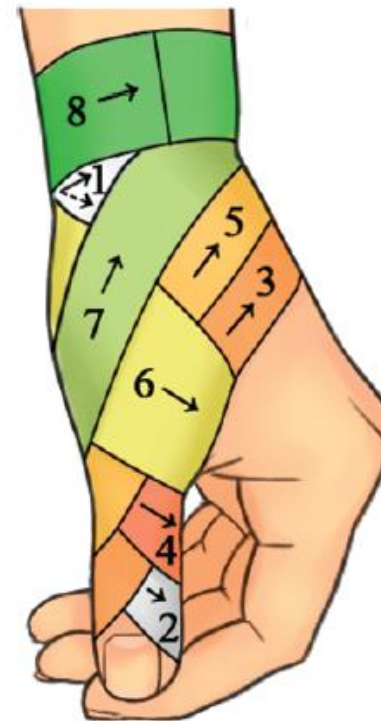
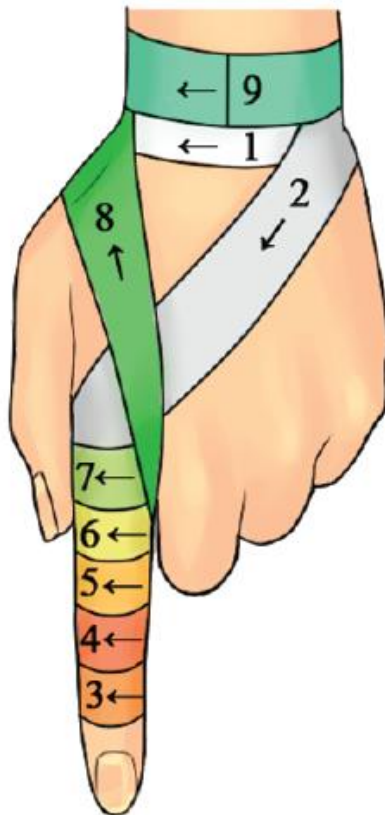
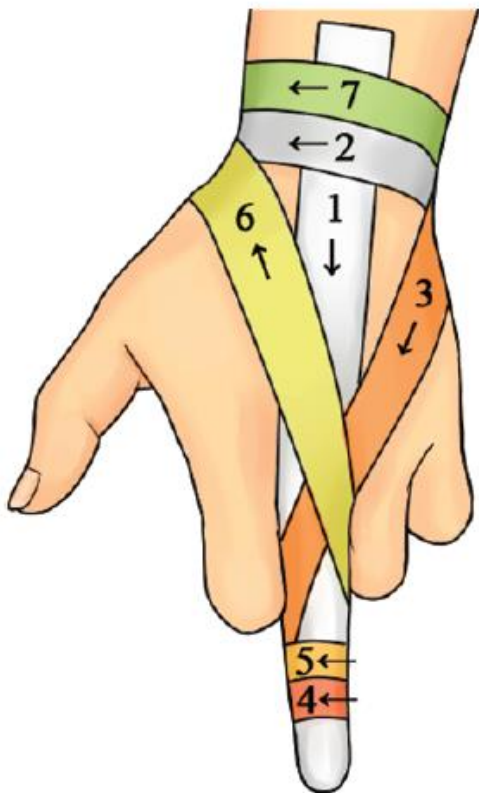
- ▶ **Показания:** ранения, ожоги всех пальцев кисти.
- ▶ Сначала накладывается вместе на четыре пальца, а затем на большой палец отдельно.
- ▶ При наложении повязки уложить стерильные салфетки между пальцами для предупреждения опрелостей.

1. Сделать циркулярный закрепляющий ход вокруг запястья.
2. Провести бинт косо к концевым фалангам по тыльной поверхности кисти. Перекинуть бинт через пальцы, и провести бинт по ладонной поверхности кисти к запястью.
3. Сделать несколько возвращающихся ходов, полностью закрывая пальцы (одной рукой бинтовать, другой придерживать повязку со стороны ладони).
4. Направить бинт косо к концевым фалангам и поменять направление бинта.
5. Вести бинт спиральными ходами от лучезапястного сустава к концам пальцев.
6. Сделать несколько поперечных циркулярных ходов к запястью, кисти.
7. Провести бинтование большого пальца руки.
8. Закрепить бинт вокруг запястья.

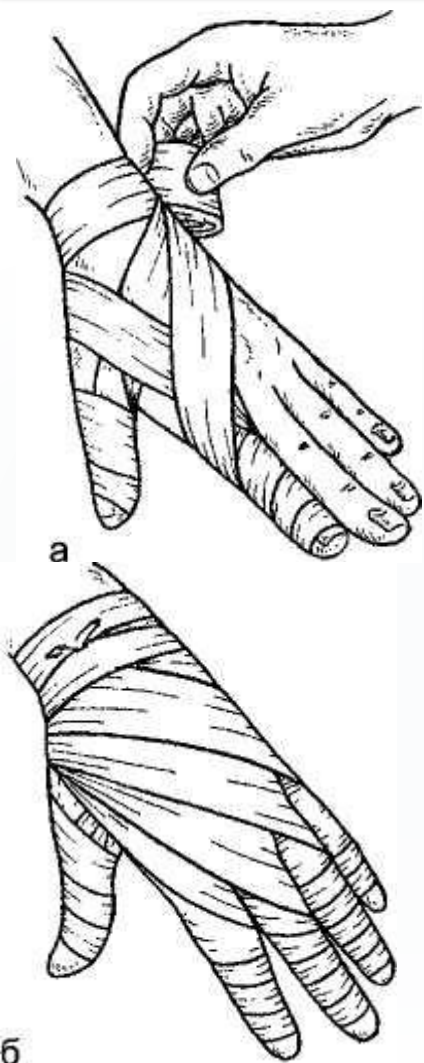
Повязка на палец



- ▶ При наложении спиральной повязки на палец начинать и заканчивать следует на кисти для предотвращения сползания повязки
- ▶ Туры с пальца на запястье должны идти только по тыльной поверхности кисти



«Перчатка»



- ▶ **Показания:** отморожение, ранения, ожоги нескольких пальцев кисти.
 - ▶ Повязка «перчатка» объединяет «спиральные повязки», наложенные на каждый палец.
 - ▶ **Правую кисть начинают бинтовать с I пальца, левую – с V.**
 - ▶ **Оснащение:** узкий бинт, ножницы.
1. Наложить 2 – 3 циркулярных тура вокруг кисти и направить бинт косо по тыльной поверхности кисти к ногтевой фаланге первого пальца.
 2. Закрыть ногтевую фалангу возвращающимся ходом бинта. Вести бинт спиральными турами от ногтевой фаланги к основанию пальца.
 3. Направить бинт на тыльную поверхность кисти косо к лучезапястному суставу. Закрепить бинт циркулярным ходом в области лучезапястного сустава и вести на следующий палец.
 4. Таким же образом забинтовать все пальцы и закрепить бинт в области лучезапястного сустава.
 5. При правильном наложении повязки ладонь остается свободной.



Повязка на культы верхней конечности

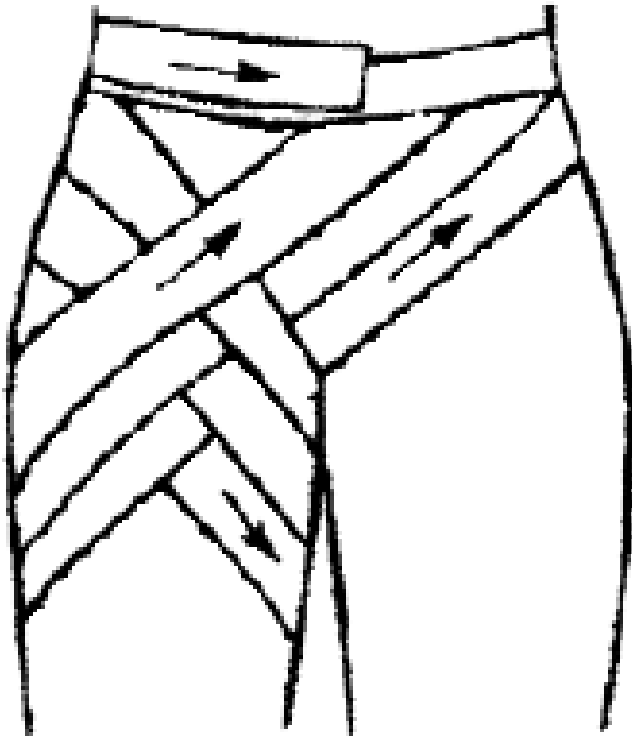


1. При ампутации плеча повязка накладывается по типу колосовидной повязки на плечевой сустав с возвращающимися ходами бинта через культю и закрепляется спиральными турами на плече
2. При ампутации предплечья повязка начинается круговым туром в нижней трети плеча, затем бинт спускается вдоль предплечья через культю его, возвращается вверх и закрепляется круговыми турами на предплечье.

Колосовидная повязка на таз / бедро

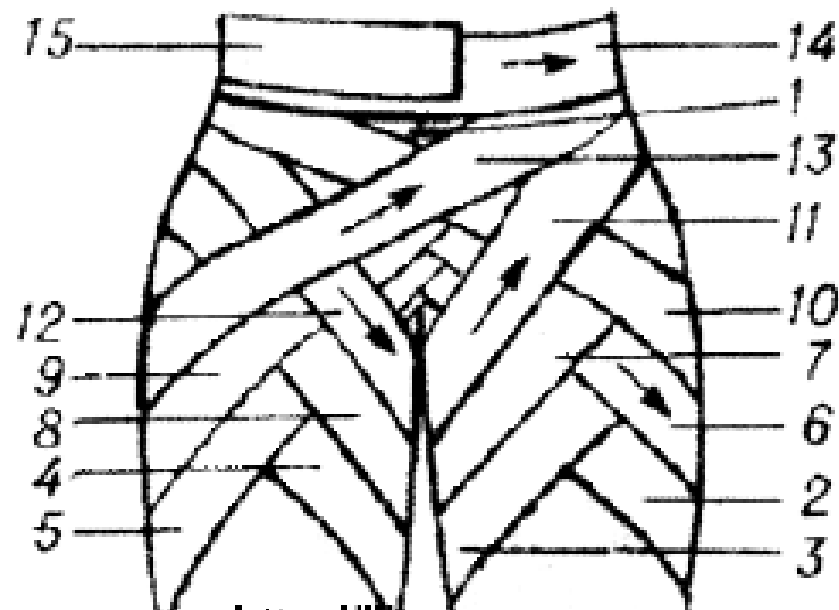


Закрывает нижнюю часть живота, верхнюю часть бедра, область ягодицы, наружную поверхность верхней трети бедра и таза и паховую область.



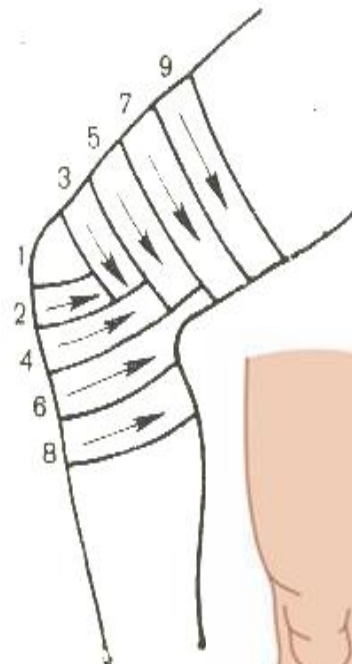
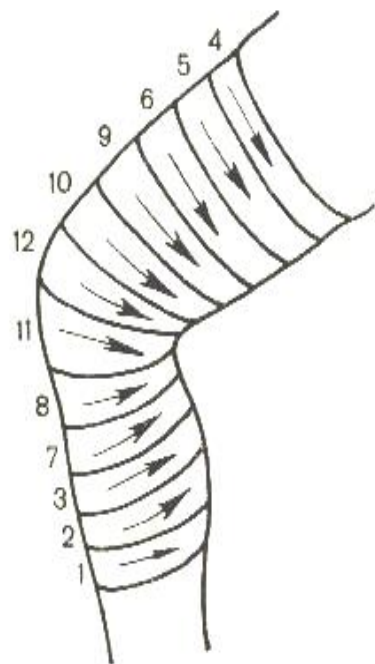
1. Круговым ходом укрепляют бинт вокруг живота,
2. потом бинт ведут сзади наперед по боковой и по передней поверхности бедра,
3. затем обводят бедро сзади и в паховой области пересекают им предыдущий ход.
4. Поднимая бинт по передней поверхности таза, им обводят туловище сзади и ведут опять в паховую область, повторяя второй и четвертый ходы.
5. Повязка закрепляется круговыми ходами вокруг живота. Перекрест туров нужно располагать по одной линии, при этом ходы бинта образуют рисунок колоса

Колосовидная повязка на оба паха



1. Колосовидная повязка на оба паха начинается круговым ходом вокруг живота.
2. Бинт ведут по передней поверхности живота через левый пах (2),
3. затем делают первые ходы колосовидной повязки левого паха (3).
4. Обойдя туловище, делают несколько оборотов колосовидной повязки правого паха (4 и 5),
5. возвращаются в левый пах (6 и 7),
6. Затем опять в правый пах (8 и 9) и т. д.
7. Повязку укрепляют круговыми ходами вокруг живота (14 и 15).

Повязки на коленный сустав и голень



а)



б)



в)

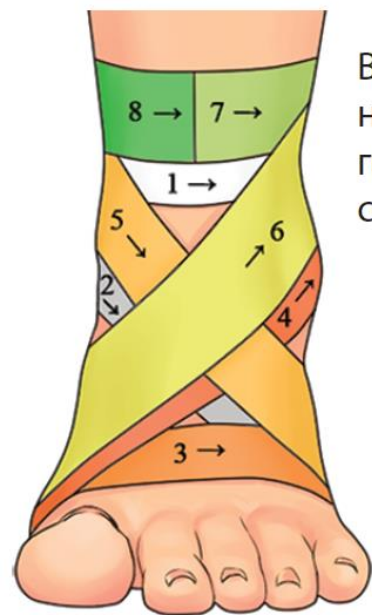
Крестообразная (8-образная) повязка на голеностопный сустав



Показания: фиксация перевязочного материала и иммобилизация голеностопного сустава (особенно при растяжениях).

При этом необходимо следить, чтобы стопа в процессе бинтования находилась под прямым углом по отношению к голени.

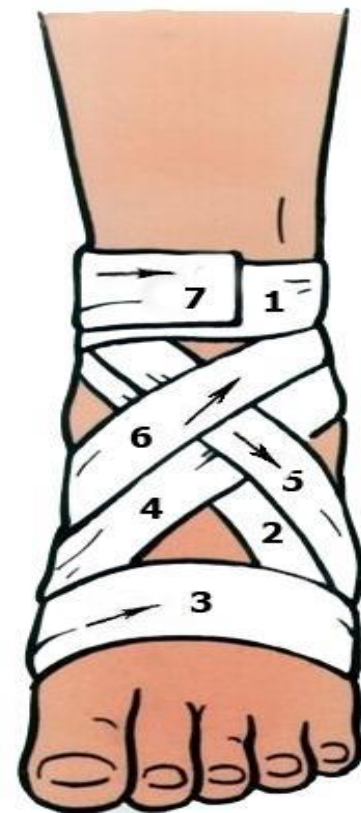
- Оснащение: бинт средней ширины, ножницы.



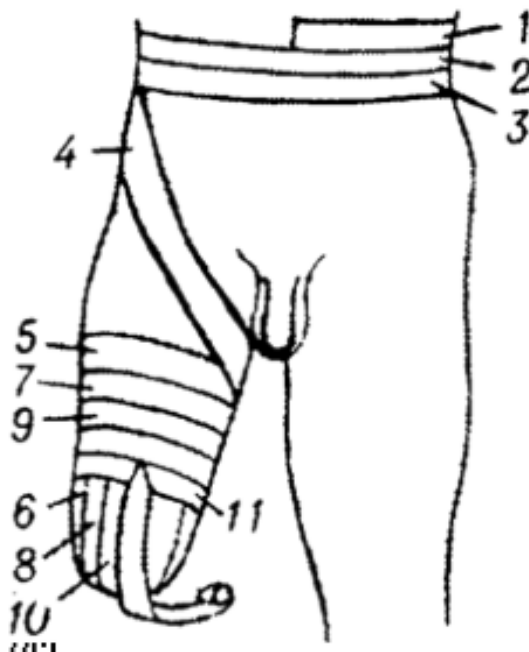
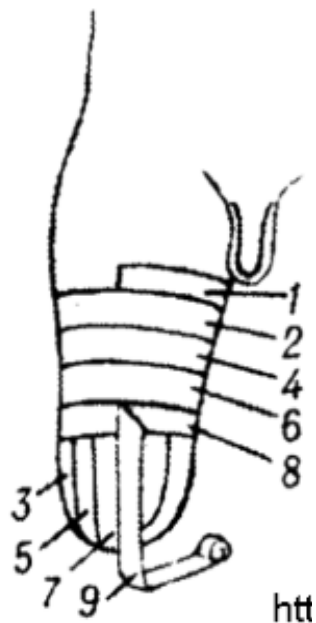
Восьмиобразная повязка на голеностопный сустав



Повязка на область пятки



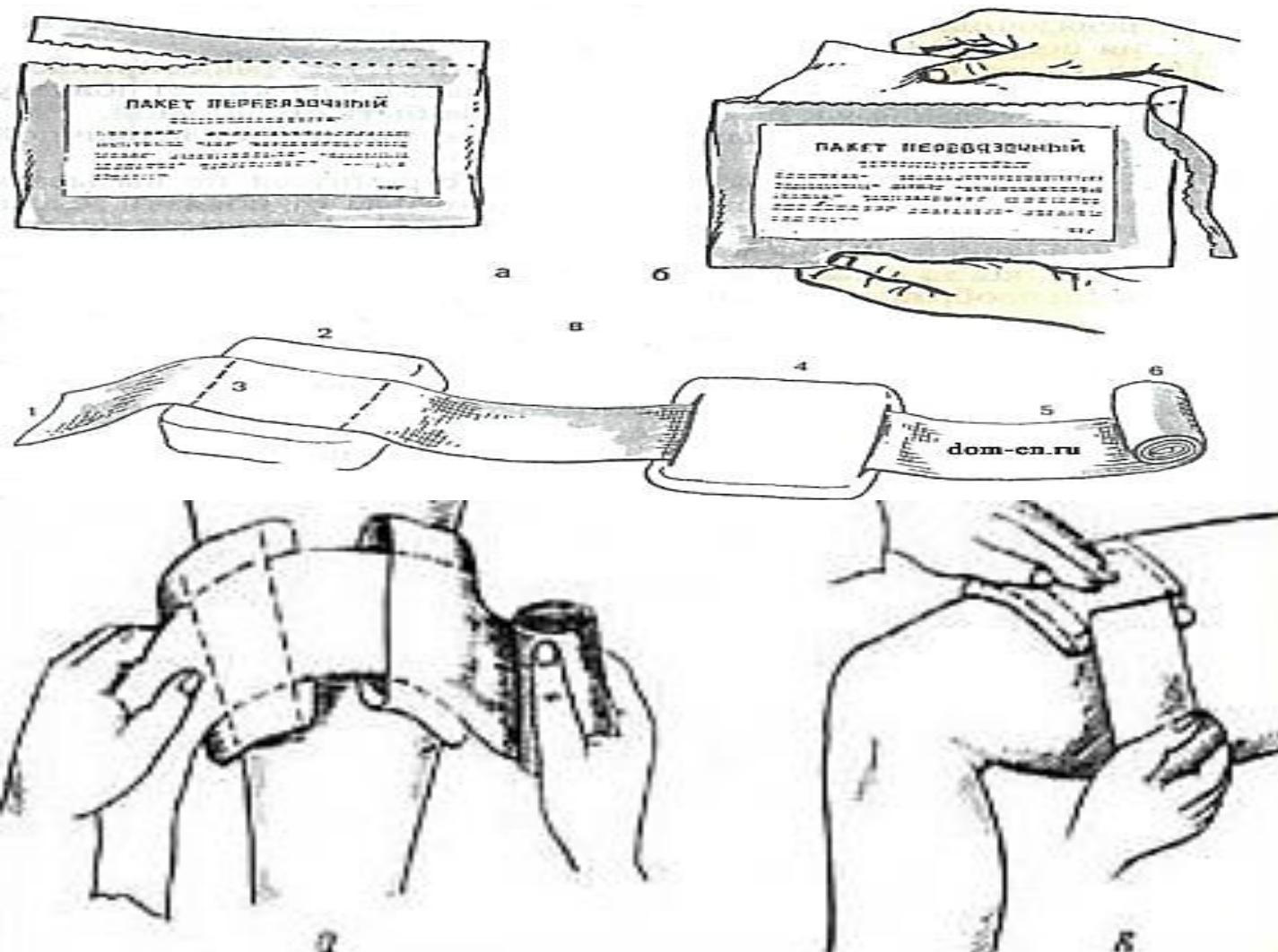
Повязка на культю нижней конечности



Для прочности ее фиксируют выше близлежащего сустава.

Например, при ампутации бедра накладывают колосовидную повязку, захватывающую паховую область, при ампутации голени повязку фиксируют выше коленного сустава и т. д.

Использование индивидуального перевязочного пакета (ИПП / ППИ)



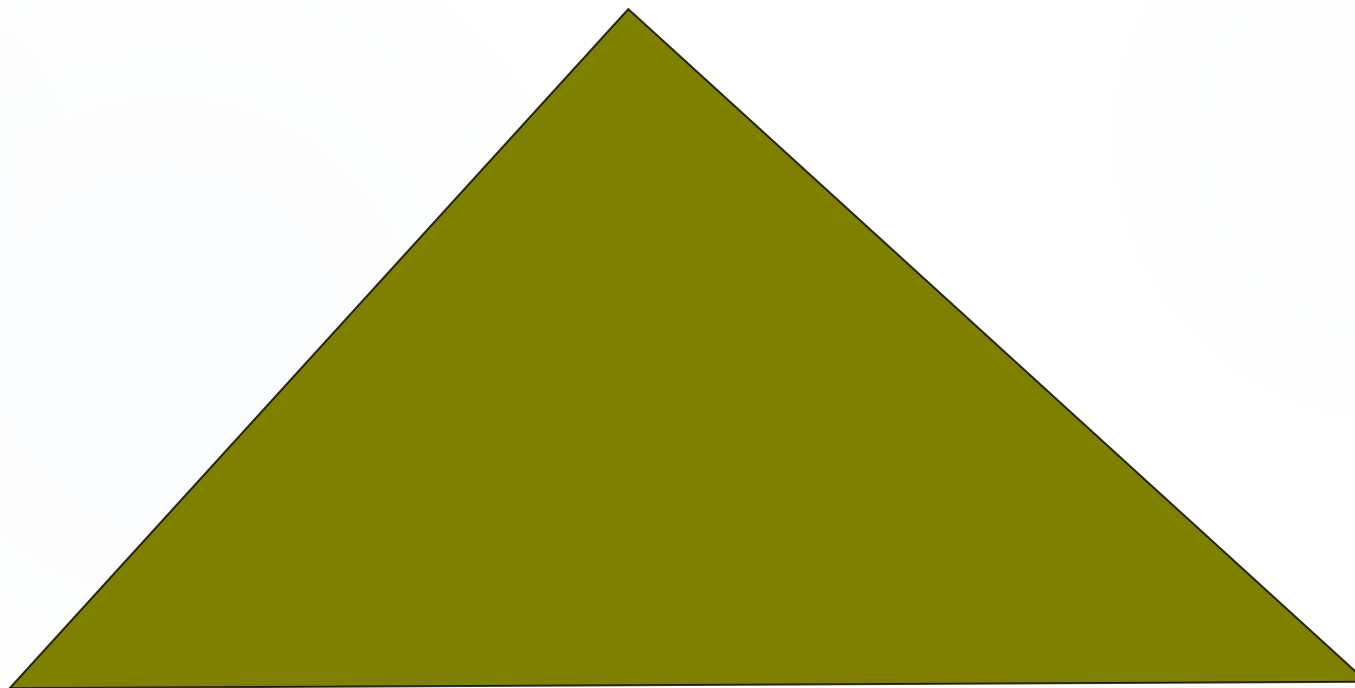


Техника наложения косыночных повязок

Косынка



Для косыночных повязок используется треугольный платок – косынка, обычно из плотного хлопчатобумажного полотна.
Размер косынки: **80*80*113 см.**



Косынки на голову



«Бандана»

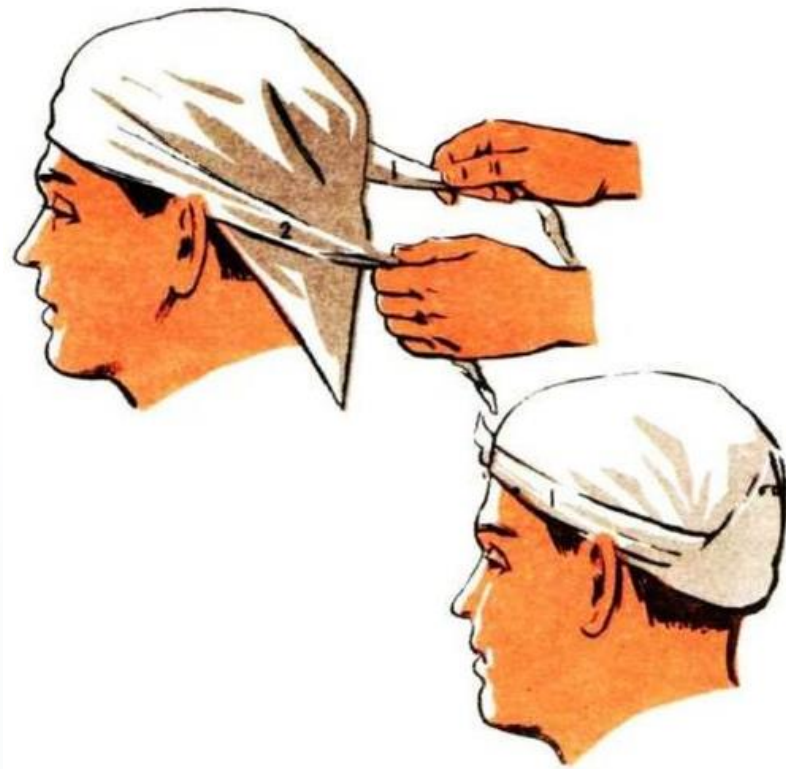


«Солоха»

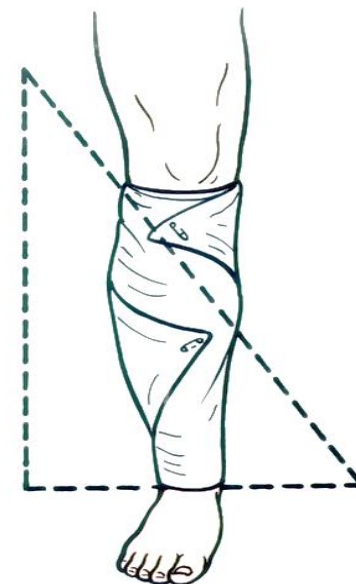
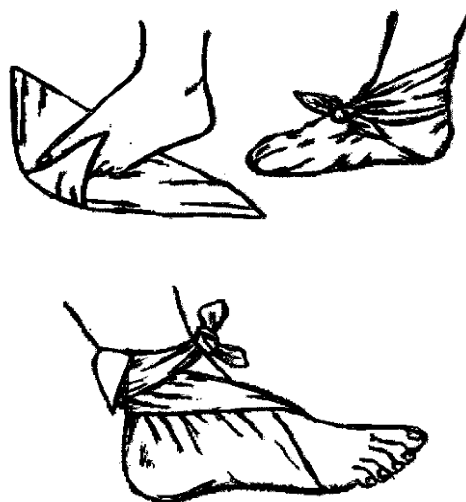


1. Усадить пациента, успокоить.
2. Объяснить ход предстоящей манипуляции.
3. Приготовить косынку.
4. Наложить основание косынки на затылок.
5. Опустить верхушку косынки на лоб и лицо.
6. Стянуть боковые концы к лобной части головы и завязать узел.
7. Завернуть верхушку косынки под узлы сверху.





Косыночные повязки на нижнюю конечность



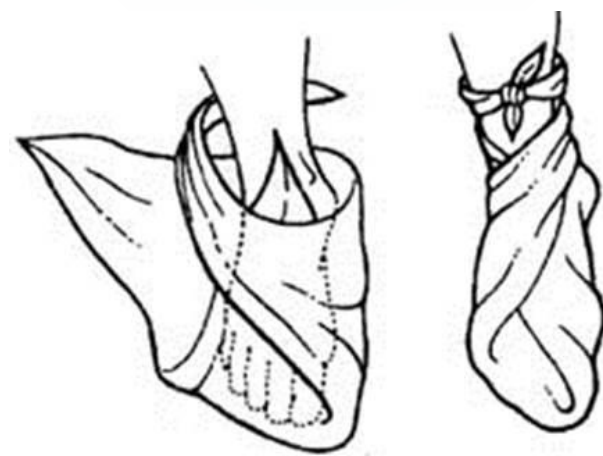
а



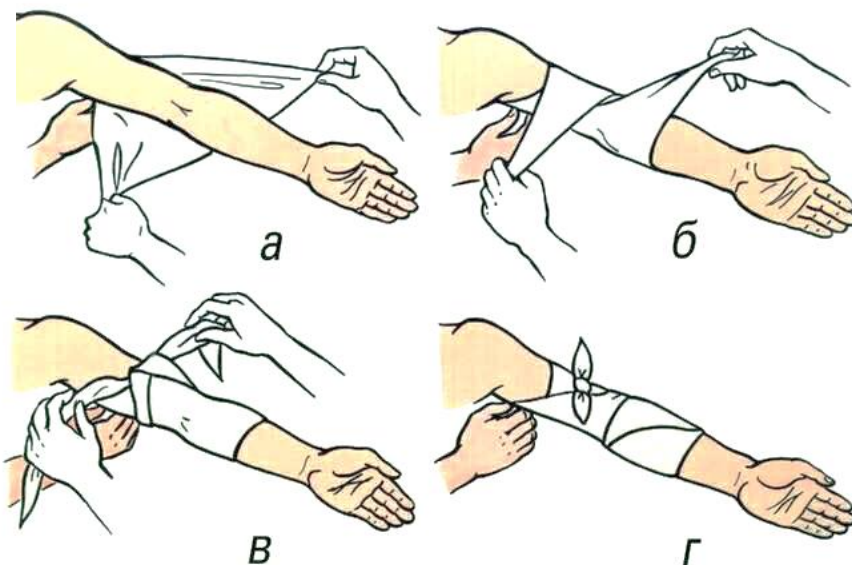
б



в



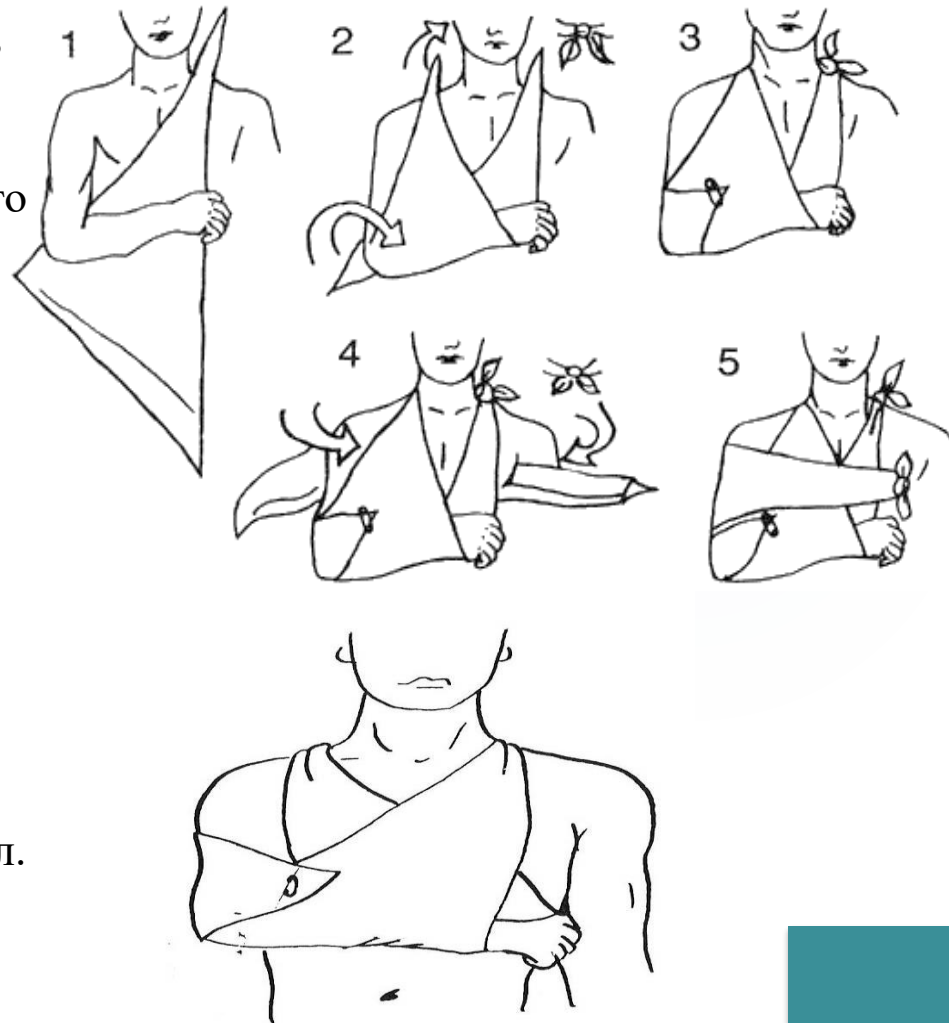
Косыночная повязка на плечо и предплечье



Косыночные повязки на локтевой сустав



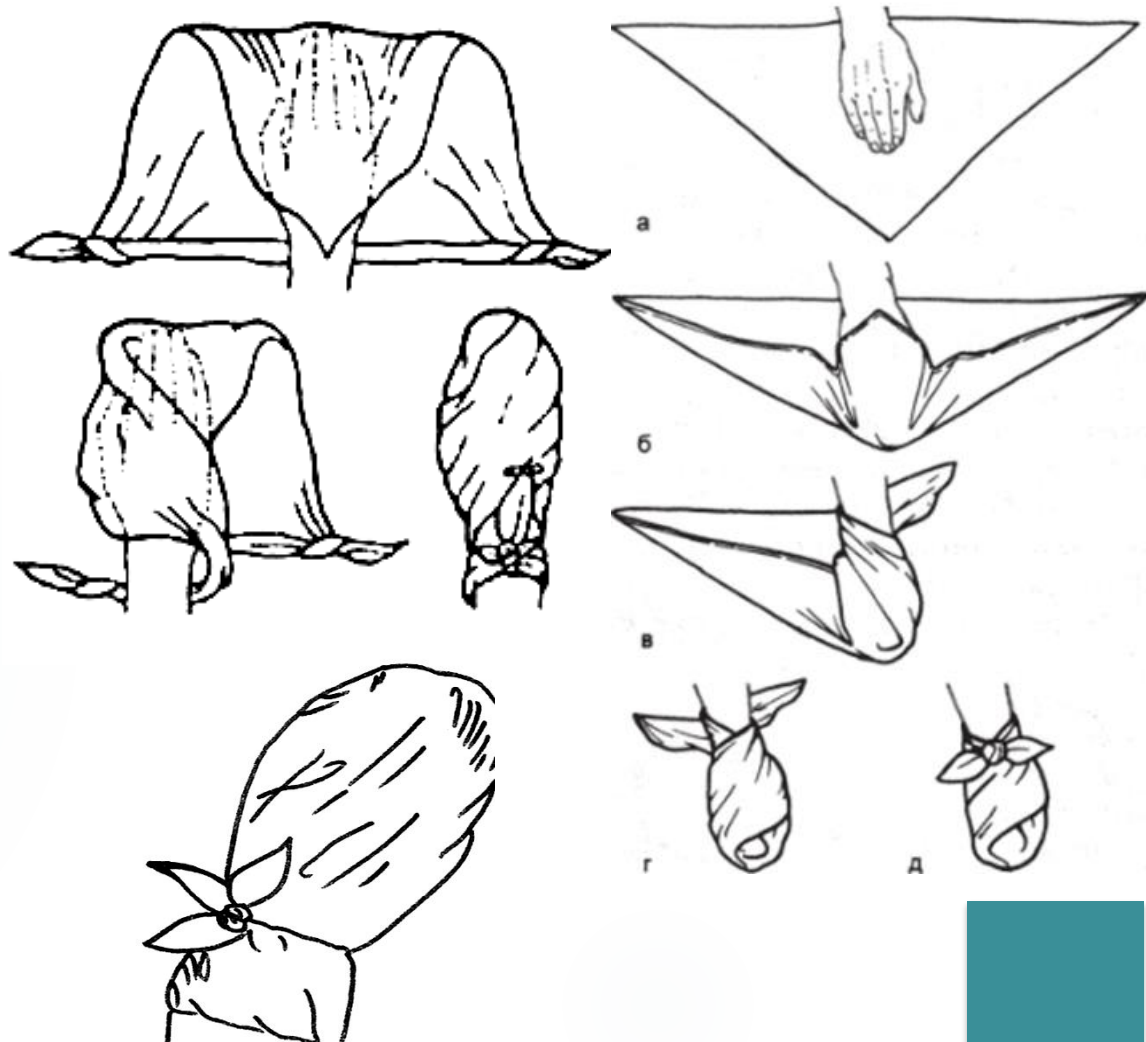
1. Усадить пациента лицом к себе, успокоить, объяснить ход предстоящей манипуляции.
2. Приготовить косынку.
3. Согнуть руку в локтевом суставе до прямого угла.
4. Поместить косынку позади больной руки: основание косынки у пальцев кисти, верхушку косынки – у локтевого сустава больной конечности, верхний конец косынки уложить на надплечье больной конечности, нижний конец косынки свешивается вниз вдоль туловища.
5. Приподнять нижний свисающий конец косынки и перекинуть через предплечье на здоровое надплечье.
6. Завести оба конца за шею и завязать на узел.
7. Завернуть локтевой сустав верхушкой косынки и прикрепить к передней ее части булавкой.



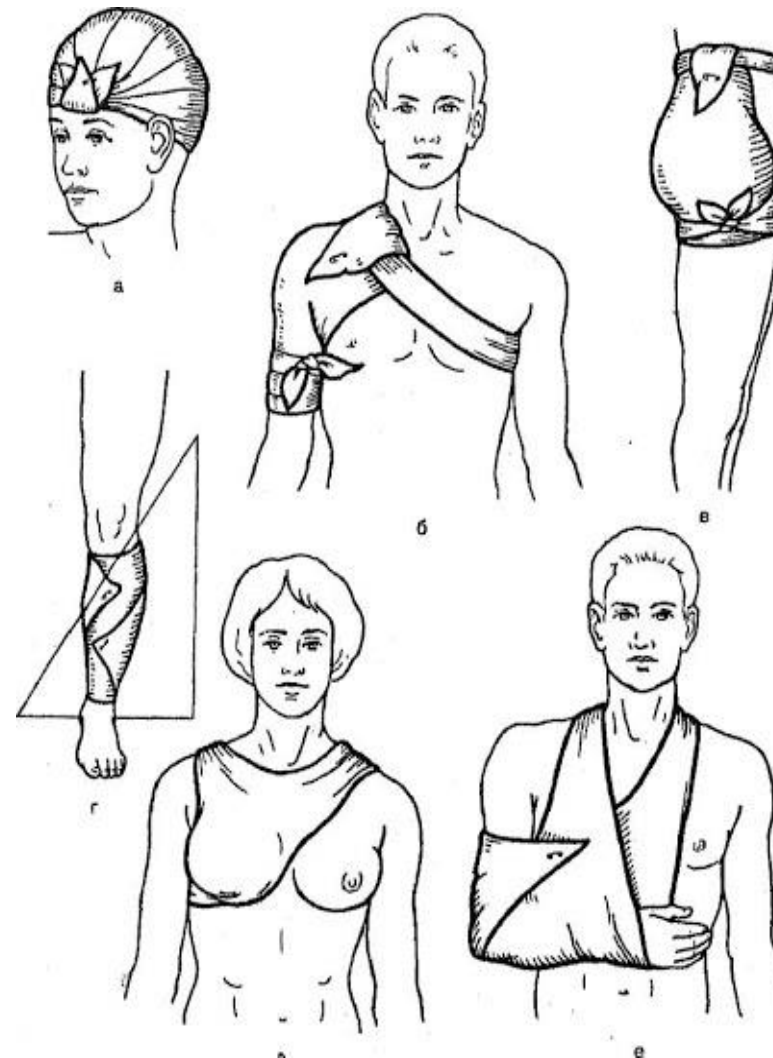
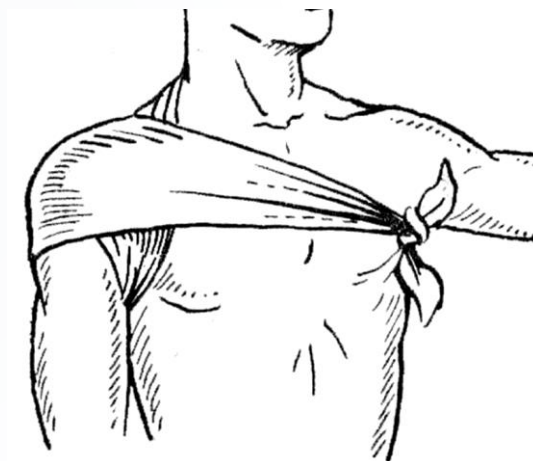
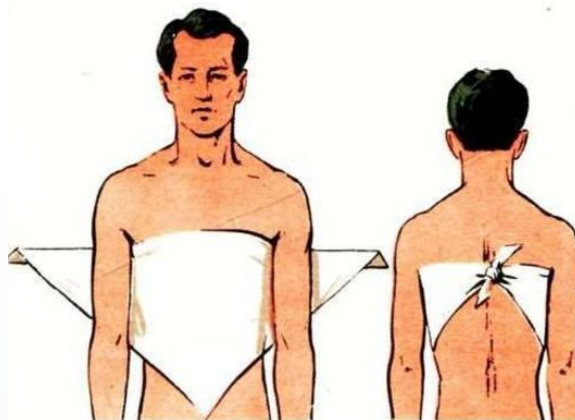
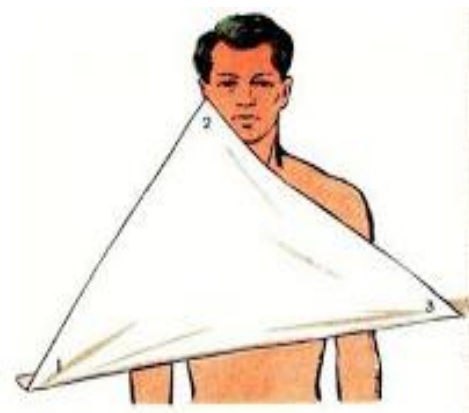
Косыночная повязка на кисть



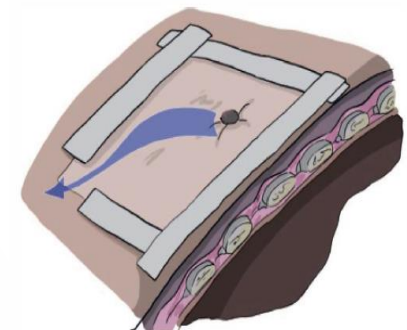
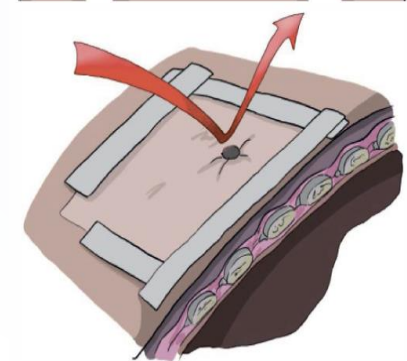
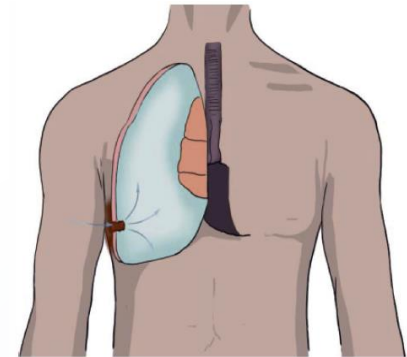
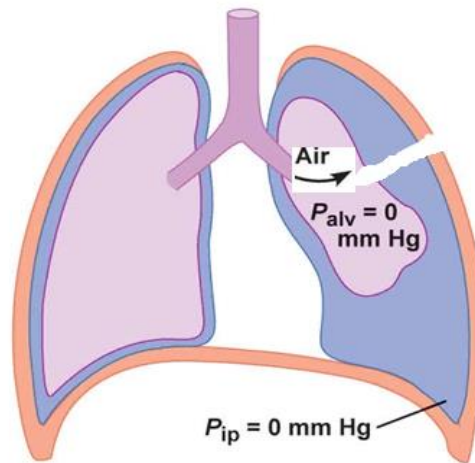
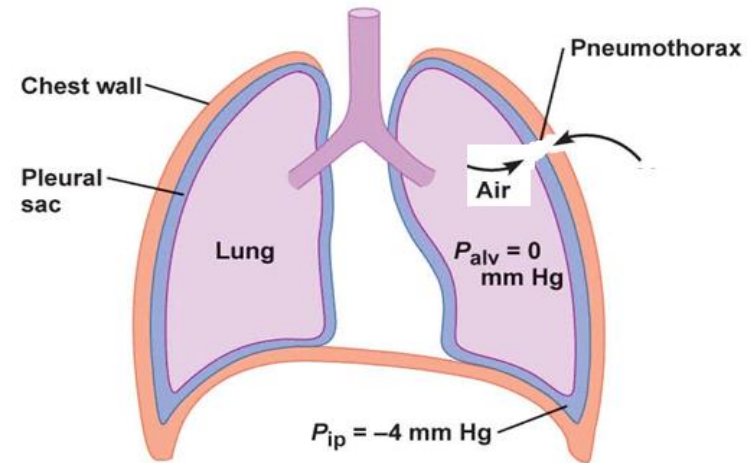
1. Усадить пациента лицом к себе, успокоить, объяснить ход предстоящей манипуляции.
2. Расстелить косынку на столе, основанием к лучезапястному суставу, вершкой к пальцам кисти.
3. Уложить кисть, а косынку (посередине).
4. Завернуть вершку косынки поверх пальцев тыльной поверхности кисти.
5. Завернуть боковые концы косынки, перехлестнуть на лучезапястном суставе и завязать узел.



Примеры косыночных повязок



Пневмоторакс



клапанная повязка
Новопласт-М
аналог Asherman Chest Seal



клапанная повязка
Радмирс
Аналог Bolin Chest Seal

Типичные ошибки наложения повязок



- ▶ Слишком туго наложенная повязка может вызвать нарушение кровообращения (боль, отек, цианоз, некроз тканей);
- ▶ Тугая повязка может быть причиной развития неврита, а в холодное время транспортировка больного с туго наложенной повязкой может привести к отморожению из-за недостаточного кровоснабжения пораженного участка;
- ▶ При слабом натяжении бинта повязка быстро сползает;
- ▶ Повязка быстро приходит в негодность, если не были сделаны первые закрепляющие туры и если одни туры бинта были наложены туго, а другие – слабо.